

广温疫论

戴天章

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

广瘟疫论卷之一

广瘟疫论卷之二

广瘟疫论卷之三

广瘟疫论卷之四

广瘟疫论卷之末

3

5

12

19

31

39

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

广瘟疫论卷之一

一辨气

风寒，气从外收敛入内，病无臭气触人，间有作臭气者，必待数日转阳明府症之时，亦只作腐气，不作尸气，瘟疫，气从中蒸达於外，病即有臭气触人，轻则盈於床帐，重则蒸然一室，且专作尸气，不作腐气，以人身藏府气血津液，得生气则香，得败气则臭，瘟疫，败气也，人受之，自藏府蒸出於肌表，气血津液，逢蒸而败，因败而溢，溢出有盛衰，充塞有远近也，五行原各有臭气，木臊，金腥，心焦，脾香，肾腐，以臭得其正，皆可指而名之，若瘟疫，乃天地之杂气，非臊，非腥，非焦，非腐，其触人不可名状，非鼻观精者，不能辨之，试察厕间粪气，与凶地尸气，自判然矣，辨之既明，治之母惑，知为瘟疫而非伤寒，则凡於头痛发热诸表症，不得误用辛温发散，於诸症，当清，当下者，亦不得迟回瞻顾矣。

二辨色

风寒，主收敛，敛则急，面色多绷急而光洁，瘟疫，主蒸散，散则缓，面色多松缓而垢晦，人受蒸气，则津液於面，头目之间多垢滞，或如油腻，或如烟，望之可憎者，皆瘟疫之色也，一见此色，虽头痛发热，不宜轻用辛热发散，一见舌黄，烦渴诸症，即宜攻下，不可拘於下不厌迟之说。

三辨舌

风寒在表，舌多无胎，即有白胎，亦薄而滑，渐传入，方由白而黄，由黄而燥，由燥而黑，瘟疫一见头痛发热，舌上即有白胎，且厚而不滑，或色兼淡黄，或粗如积粉，若传经入胃，则兼二三色，又有白胎即燥，与至黑不燥者，大抵疫邪入胃，舌胎颇类风寒，以兼湿之故而不作燥耳，惟在表时舌胎白厚，异於伤寒，能辨於在表时，不用辛温发散，入时而用清凉攻下，斯得矣。

四辨神

风寒之邪伤人，令人心知所苦而神自清，如头痛作寒热之类，皆自知之，至传入胃，始神昏，缘风寒为天地正气，人气与之乖忤而後成邪，故其气不昏人神情也，瘟疫初起，令人神情异常而不知所苦，大概烦躁者居多，或如痴如醉，扰乱惊悸，及问其何所苦，则不自知，即间有神清而能自主者，亦多梦寐不安，闭目即有所见，有所见即之根，缘瘟疫为天地邪气，中人人病，中物物伤，故其气专昏人神情也。

五辨脉

瘟疫之脉，传变後与风寒颇同，初起时与风寒迥别，风寒从皮毛而入，一二日脉多浮，或兼紧，兼缓，兼洪而皆浮，迨传入，始不见浮脉，其至数亦清楚而不模糊，瘟疫从中道而变，自出表，一二日脉多沉，迨自出表，脉始不沉，乃不浮不沉而数，或兼弦，兼大而皆不浮，其至数则模糊而不清楚，其初起脉沉迟，勿作阴寒断，沉者，邪在也，迟者，邪在阴分也，脉象同於阴寒，而气色，舌胎，神情，依前诸法辨之，自不同於阴寒，或数而无力，亦勿作虚视，缘热蒸气散，脉不能鼓指，但当解热，不宜补气，受病之因有不同，故同脉而异断也。

辨时行疫疔与风寒异气

风主疏泄，寒主凝泣，二气虽有不同，然皆冷而不热，其中人也郁而不宣，方其初受在表，均宜温散，麻黄汤，桂枝汤，芎苏，十神，神术等方，皆散寒之剂，非解热之剂，时行之气，属湿温二气合成，热而不冷，其中人也，立蒸而腐败，方其初传在表，即宜凉解，大青龙汤，六神通解散，九味羌活汤，葳蕤汤，大羌活汤，人叁败毒散，皆解热之剂，非散寒之剂也，以解热之剂治风寒，轻则寒中呕利，重则厥逆亡阳，以散寒之剂治瘟疫，轻则衄渴，重则枯竭亡阴，此气之不可不辨也。

辨时行疫疔与风寒异受

风寒从表入，自皮毛而肌肉，而筋脉，而胸膈，而肠胃，一层渐深一层，不能越此而入彼，故汗不厌早，下不厌迟为和，为解，浅深毫不可紊，以其气皆属冷，一层收敛入一层，必待寒化为热，邪敛入内，方可攻下凉解，否则邪未入，预用攻利凉解，虚其气，反引表邪内陷，而成结胸痞利诸险证也，时症从口鼻而入，先中中焦，後变九传，其传自出表，虽出表，而未必全无邪留，经过之半表，未必全无邪干，故下不厌早，汗不厌迟，为和，为解，浅深必不可拘，以其气皆属热，热能作蒸，不必郁变，而此蒸即带彼热，当其未出表时，强欲温表，在始则引毒热成燎原之势，为斑衄狂喘诸凶，在末则伤真阴，为枯槁沉昏厥逆诸危也。

辨传经

温疫传经，与风寒不同，风寒从表入，故必从太阳而阳明，而少阳，而入胃，若温疫则邪从中道而出表入，惟视人何经本气之强弱为传变，故吴又可曰，疫邪有先表後者，有先後表者，有但表不者，有但不表者，有表胜於者，有胜於表者，”二句，吴又可本，作有表偏胜者一句〔，有表而再表者，有而再者，有表分传者，此为九传，愚按所谓表者，发热，恶寒，头痛，头弦，项强，背痛，腰疼，腿膝足胫酸痛，自汗，无汗，及头肿，面肿，耳目赤肿，项肿

，发斑，发疹皆是，所谓者，渴，呕，胸满，腹痛，胁满，胁痛，大便不通，大便泄泻，小便黄赤涩痛，及烦躁，沉昏，舌燥，舌卷，舌强，口咽赤烂皆是，在风寒从表入，症必待渐次闭郁而成，故见表症，不必兼见

症，且入之後，表多自解，故见

证之後，不必复见表证，若温疫本从中道而出表，故见表症时，未有不兼一二

症者，且未有不兼见一二半表之少阳证者，仲景所云，阳明少阳合病，必自下利，三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗，三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁而面垢，遗尿，皆指瘟疫言，非指风寒言也，且瘟疫属蒸气，出表入

，原自不常，有入下之，而余邪不尽仍可出表者，尝见沉昏之後，病愈数日，

复见头疼发热，复从汗解者，此所谓表而再表，风寒必无是也，更有下证全具，用承气汤後，气通而表亦达，头痛发热得汗而解，移时复见舌黑胸满，腹痛，仍待

大下而後愈者，此所谓而再，风寒必无是也，若夫表分传之症，风寒十无

一二，疫症十有六七，但据传经之专杂以辨之，一经专见一经证者多风寒，一经杂见二三经证者多疫症，日久渐转属者多风寒，一日骤传一二经，或二三经者多疫症，则虽病有变态，而风寒不混於疫症，疫症不混於风寒，施治自无讹误矣。

至若辨气，辨色，辨舌，辨神，俱已清楚，而投之以治疫之药复有不效者，则以时疫有独发，有兼夹他症之故，是以辨时疫，异於他症矣，至挟他症者，则此人时疫与彼人时疫，又有不同，尤当细辨，其兼症凡五种，夹症凡十种，详列於後。

兼寒其一，有兼寒者，初起一二日，头痛，发热，身痛，恶寒，诸表症悉与时疫同，而以脉辨则不同，时疫多软散而不浮，兼寒则多浮数，浮弦，浮大，甚至有浮紧者，再以症辨，亦微有不同，时疫多汗，兼寒则无汗，为异，亦异於单受寒者，单受寒，无烦躁，口苦，口臭症，时疫兼寒，必有烦躁，口苦，口臭证也，一遇此等，更当辨其受寒与时疫孰轻孰重，疫重寒轻者烦躁症多，无汗恶寒症少，则当以败毒散，加知母，石膏，或达原饮，加羌，防，柴，葛，或六神通解散尤捷，寒重疫轻者恶寒无汗症必甚，烦躁必轻，则只用败毒散，其寒束於外，无汗恶寒既甚，疫郁於内，烦躁更甚者，冬月大青龙汤可借用，馀月九味羌活汤最为的当，此症若治寒遗疫，必有斑，黄，狂，衄之变，治疫遗寒，复有厥逆，呕利，胸腹痞满之忧，驯至沉因者不少，不可不知，然此皆为初起一二日言也，若日久则邪疫勃发，表寒不能自存，而变为热，则惟以治疫之法治之而已。

兼风其一，有兼风者，初起一二日，表症与时疫悉同，惟鼻塞，鼻鸣，嚏喷，咳嗽，与时疫略异，脉亦多浮，而与时疫之不浮不沉而数者微异，治法不大相远，即於时疫诸方中加荆防，咳加前胡，杏仁，苏子而已，大抵时疫兼寒，能令病势增重，兼风，反令病势易解，以寒主凝泣，则疫邪内郁，郁一分，病势增痼一分，风主游扬，则疫邪外疏，疏一分，病势解散一分。

兼暑时疫兼寒，兼风，四时皆有，至若兼暑一症，惟长夏有之，初起一二日，与时

疫无异，只胸满呕利为异，而脉则兼弦，细，芤，迟，不似时疫不浮不沉而数，治法於时疫诸方中，微减发表之味，如用羌即不用独，用柴即不用前，盖时疫多汗，暑症更多汗，两邪逼出表汗，则表必虚，故发表之味，不可重复也，寒润之药尤宜减，清热之味亦宜减，以邪从表出，郁热必轻，过用清凉，恐致寒中而增呕胀泄利，况表气太泄，气必虚，易犯厥脱之症，故清凉寒润，不可太多也，最宜加用分利燥脾之品，木通为上，滑石次之，猪苓，赤茯苓，泽泻又次之，盖分利则暑与疫皆从清道而出，邪有去路，正不必徒以寒凉逆折取效也，间有表见身痛，宜用香薷，见腹满，宜用苍术者，再时疫兼暑，则病势反缓，以疫中温气属亢阳，暑为阳中之阴，阳得阴则解，虽不能尽解，然得一分阴气，则和一分亢阳，每见时疫兼暑，其舌燥诸证反缓者，职此故也。

兼症时疫有似症，有转症，有兼症之不同，用药亦有微异，似症者，寒热往来，或一日二三次，或一次而时无定也，时疫初起多有之，转症者，

时疫偷妄烦渴大剧之後，已经大汗大下，仍有馀邪不解，复作寒热，转成疟象也，时疫末路多有之，兼症之症，乃寒暑时疫合病也，其症寒热有常期，疟症全具，但热多寒少，且多燥渴扰乱，热势迅速，神情昏愤，秽气触人为异，秋令多有之，时疫所以似疟者，因邪气盘错於募原，欲出表而不能透达，欲陷而未得空隙，故见半表半里之少阳症也，治法宜达原饮加柴胡为主，时疫所以转疟者，因汗下後邪气已衰，正气来复，邪正相争，故在先阳气独亢，有热无寒者，今则以阴液渐回，而寒热相争矣，在先邪气秉纲，昼夜燥热无休止时者，今则邪气渐退，正气渐复，而寒热发作有时矣，治法以养正为主，祛邪佐之，小柴胡汤，炙甘草汤，柴胡四物汤，叁胡三白汤，量馀邪之盛衰，视阴阳之盈亏，酌而用之，至若兼症之症，最为难治，吴又可曰，疟疾二三发，或七八发後，忽然昼夜烦热，发渴，不恶寒，舌上胎刺，心腹痞满，饮食不进，下症渐具，此时疫症见，疟疾隐也，以疫症方药治之则生，疟家方药治之则剧，治之如法，脉静身凉，每日，或间日，寒热复作有常期者，时疫解而疟邪未尽也，仍以疟法治之，愚按时疫与疟病，不甚相远，疫乃湿温二气合病，疟乃风寒暑湿四气合病，其邪气之杂而不纯相类，疟邪横连募原，时疫亦发於募原，其受邪之处相类，但时疫之温气，发则为亢阳，故宜下宜清之症多，疟之暑气，停则为郁滞，故宜宣利之症多耳，所以时疫初起，方用达原饮，与疟之主方用清脾饮，药品亦多相类，至其传变，则缓急轻重，迥乎不同也，善悟者於此处细叁，思过半矣。

兼痢时疫本多自利症，表症初起，即每日解数次稀臭水者是也，详见後自利条下，有春夏之交，得时疫即兼下利红白而急後重者，名为疫痢，初起慎不可从痢治，盖痢属证，今兼疫邪之发热头痛，为表裏俱病，先用治疫之法解其表，表解而自和，其痢多有不治自愈者，若用治痢之法先清其里，气虚而表邪陷，轻者增其烦躁沉困，重者遂至呕逆昏愤而危矣，所以古人於疫痢初起专主仓廩汤，其方乃人

叁败毒散，一意解表，但加陈仓米以和中养脾胃，俟表证解後，热症具，方可议清议下，不但香连，芍药，承气之类宜缓，即淡渗分利之剂，亦宜缓投於表症未解之先也，若太阳症不见，而微见少阳，阳明症者，则柴葛五苓散不妨借用，痢症夹表，不可清，不特时疫兼症为然，凡一切痢症微兼身热，即宜慎用苦寒淡渗，用之若早，必增呕逆，此历验不爽者，疫症兼利，其热势反多缓，亦由痢为暑气，阳中之阴，能和亢阳，且郁蒸之热，有所疏泄故也，若疫毒太甚，骤发即下纯红，纯紫恶血，或兼见舌烦诸恶症者，黄连，大黄，又在急用，不可拘此论矣。以上五条，其辨明所以为瘟疫兼症，固已不憚逐类详审，然总以前所备具气，色，舌，神，脉五辨为主，五者之中，必有一二确据，方於疫门求治，否则各按各门施治可也，若混以时疫治之，为害甚矣。

夹痰水饮入於胃，经蒸变而稠浊者为痰，未经蒸变而清稀者为水，痰与水，一物也，痰能作热，水能作冷，时疫属热症，故夹痰者，更增其热，脉症治法，无甚叁差，但於治疫药中加瓜蒌，贝母，甚则加牛黄，夹水者，脉症往往相悖，治法则有不同，不可不细辨也，时疫之脉必数，而夹水在胸膈，其脉多缓，甚则迟弦，此脉夹水之辨也，时疫之舌，一经传，即转黄，转燥，转黑，若有水在胸膈，则烦躁沉昏诸症备具，而舌色白润，间有转黄黑者，亦必仍有白胎，或满舌黄黑，半边夹一二条白色，或舌尖舌本俱黄，中夹一段白色，此舌夹水之辨也，时疫胸满，心下硬痛，手不可按，一有水在胸膈，心下虽满痛，按之则软，略加揉按，则漉漉有声，此症夹水之辨也，时疫见夹水脉症，虽有表，不宜纯用辛凉发散，纯用辛凉，则表必不解，而转见沉困，有症，不可遽用苦寒，早用苦寒，必转加昏愤，此水气郁遏热邪，阳气受困，宜於发表清药中，加辛燥利气利水之品以祛水气，迨水气去，郁遏发，然後议攻议凉，则无不效者矣，燥湿则半夏，苍术，利水则木通，苓，泽，利气则莱菔，草果，木香，甚至有须用大戟，芫花者，在时疫虽属热邪，往往有投三承气，黄芩，白虎而不效，偶用温暖药收功者，遂相讼清热之非，不知热邪乃其本气，夹杂乃其间气也。

夹食时疫夹食者最多，而有食填膈上，食入肠胃之不同，入肠胃则为阳明诸热症，治法备於三承气汤，惟食填胸膈，往往有脉沉手足冷者，误认三阴，投以温剂，亦无一毫热渴发见，但烦躁倍增，甚则一二日即死，盖胸中乃阴阳升降之路，食填之，则气闭，气闭，则热郁於下，而无所疏泄，误温则热愈郁，热郁於内，故外无发热症，热郁於下，故上无口渴症，疫热以出表为轻，人为重，在浅为轻，入深为重，此症一温，则逼邪入入深，以致速死而无热症也，如气，色，神，舌，脉，辨得为疫症矣，而遇脉沉手足冷，即当细询其胸膈，若痞塞闷满，即是夹食，再辨其舌胎白厚而微兼淡黄，益为食填膈上之明验，於治疫药中加枳，桔，青皮，莱菔，曲蘖，甚则用吐法以宣之，使膈开而阳气宣达，然後热症自见，当解表，当清自无误治矣。

夹郁时疫夹气者，初起疫症悉同，而多脉沉，手足冷，呕逆胸满，颇类夹食，但

夹食为有物，为实邪，舌胎厚白而微黄，胸膈满痛不可按，而亦不移，夹气为无物，为虚邪，舌胎白薄，胸膈满痛串动而可按，宜先宣通其郁，然後解表消，自无不效，若不舒郁而徒发表，则气不能外达而难於彻汗，遽用清下，则上气不宣，多致痞逆，惟於解表药中，加苏梗，木香，大腹皮，香附等类，以宣其气，则表易解，於清药中，加川贝母以舒其郁，则易和，贝母为舒郁要药，但力性缓，必用至五钱，一两，方能奏效。

夹血时疫传之後，畜血最多，治从攻，兹不具论，惟本有内伤停瘀，复感时疫，於初起一二日，疫之表症悉具，而脉或芤或涩，颇类阳症阴脉，但须细询其胸腹胁肋四肢，有痛不可按而濡者，即为畜血确验，其芤涩，非阳症见阴脉，乃表症见脉也，治法必兼消瘀，红花，桃仁，归尾，赤芍，元胡之类，量加一二味，表邪方易解，涩芤之脉方易起，若误认芤涩为阴脉而投温剂，轻者变剧，重者危矣。

夹脾虚时疫较之风寒，本为难治，以风寒传变有次序，时疫传变无常经，风寒表邪，一发即散，时疫散而复集，且往往复之再三，风寒传症，一攻即和，时疫攻而复合，有下之一二十次者，此时疫之难治也，而脾虚者更为难治，盖时疫必得汗下而後解，脾虚者，表不能作汗，不任攻下，或得汗矣，而气随汗脱，得下矣，而气从下脱，治此等症，汗勿强汗，发表必兼养正，人叁败毒散是也，下勿轻下，攻必兼固气生津液，黄龙汤是也，其外症无大分别，惟脉不任寻按，然邪有进退，当其邪进方张之时，脉亦有寻按有力者，不可泥也，必合气色神情脉证以细叁，如面色痿黄，神情倦怠，气息微促，及心悸耳鸣，皆脾虚中气不振之象，更须通体合叁，如通体皆见有馀实象，而独见一二虚象，则虚象反为吃紧，通体见虚象，而独见一二实证，则实证又为吃紧，总须权衡标本，凡证之属表，属上焦，属六腑者，皆为标，证之属，属中焦，下焦，属五脏，皆为本，若实症居标，虚证居本，则虚证为重，虚证居标，实证居本，则实证为重，到此虚实关头，必着意叁详，庶几无失。

夹肾虚时疫夹脾虚者，为难治矣，夹肾虚者，更难，时疫属热症，肾气虚则手足冷，时疫属实邪，肾气虚则眩晕惊悸，腰膝痿软，肾虚之中，又有阴虚，阳虚之分，时疫必待汗、下、清而後解，阳虚者，一经汗、下、清，则脱绝之症随见，阴虚者，一经汗下，则枯竭之症随见，必须时时谛察，凡在表时，见腰痛异常，小便频数，膝胫冷软，其人平日非有淋浊阳痿，即系遗泄好内，须询明，于通表药中加人叁，白芍，阳虚兼杜仲，阴虚兼知母，以照顾肾气，免後來意外之变，若入当下，必以陶氏黄龙汤为主，当清，必以人叁白虎汤为主，或屡清屡下而热更甚，舌上燥而无胎，或有黑胎，愈清而愈长，或有燥胎，愈下而愈燥，此皆肾虚之证，察其阳明，无实邪可据，当从肾虚治以六味地黄汤，易生地，加知柏，王太仆所谓寒之不寒，责以无水，壮水之主，以制阳光者，此也，或仍不应，则合生脉散以滋水之上源，或用四物汤流通经络，似此热势燎原，非杯水所能救，必大作汤液，药味必以两计，汤液必以斗计，乃有济耳，见几早，十救二三，涸竭已见，十难救一，或更

兼脾胃败症，如呕呃哕利之类，汤药不下，百难救一矣。

夹亡血疫症亡血有三，其一，未病之先，素亡血而阴虚，一受疫则邪热乘虚煎熬，亡阴最易，解表清，用药必步步照顾荣血，如九味羌活汤之用生地，人参败毒散之用人参是也，其二，当受病之时，忽然吐衄，女子崩漏，甚至血晕昏厥，势甚危急，亦疫症常有也，病家但知血之可骇，往往不知受疫，医家亦忽其客邪，惟汲汲于止血，清凉滋补，多至危殆，不知血由疫逼，惟当治疫，疫邪解而血自止，此症不遽见於疫在表时，而见於发热数日之後，人犹易知，惟疫郁於阴经而暴见此症者，难识，以其症外无头痛发热之可据耳，但见微恶寒而大作呕，急当视其气，色，神，脉，舌胎，若舌有白胎，气色有一二疫象，即是疫毒无疑，以达原饮为主，呕加藿香，胀加青皮，但治疫毒，血症自己，若脱血太甚，而气欲绝者，加人参以固中气，俟疫症传变归经，然後按经治之，此疫症兼血之最危者，其三，疫邪大张之後，烦热躁渴之馀，而见亡血证，则又瘟疫常态，详後血症各条。

夹疝疫邪夹疝，其肾囊少腹引痛，全是疝症，当照辨气，色，神，脉，舌胎法辨之，有疫邪，不必治疝，但治疫而疝自消，若依常治疝，用吴茱，桂，附，茴香诸燥品，轻者变为囊痈，重者呃逆哕厥沉昏而莫救矣。

夹心胃痛时疫有兼心胃痛者，於其痛时，察其气，色，神，脉，舌胎，若有一於时疫，但治时疫，虽平时因寒而发，此则惟治其热，盖以疫邪客於募原，传於太阴，而发心胃痛之痼疾，於达原饮中加木香，苍术，以开通郁疫，使其透发於表，而痛自己，若误认平常心胃痛，用桂，附，姜，茱，必致危殆，

夹哮喘哮喘，乃肺家素有痰火，一受疫邪，其湿热之气，从其类而入肺，发其哮喘，遇此当察其气，色，神，脉，舌胎，有疫但治疫，其哮喘自除，于治疫药中加贝母，瓜蒌，淡豉，桑皮，疫邪哮喘并解，法更精密。

以上诸条，凡言兼者，疫邪兼他邪，二邪自外入者也，凡言夹者，疫邪夹内病，内外夹发者也，二邪兼发，以疫为重，他邪为轻，故略兼治他邪而病即解，二邪夹发，如夹水，食，血，气，痰，等实邪，则以夹邪为先，疫邪为後，盖清其夹邪，而疫毒始得透达，透达方能传变，传变方能解利也，如夹脾虚，肾虚，亡血诸虚症，则以治邪为主，养正为辅，盖疫邪最易伤正，故不可养正遗邪也，如夹疝，哮，心胃痛诸旧病，则但治疫邪，旧病自己，盖旧病乃新邪，所迫而发也。疫邪见症，千变万化，然总不出表 二者，但表证中有 邪，症中有表邪，则又不可不细察也，故列证分表以尽其常，又细辨以尽其变，使人一目了然，胸有定见，稍救横夭於万一耳。

广瘟疫论卷之二

表症

发热时疫发热，与风寒杂症同，其发热时，气，色，神，脉，舌胎则不同，辨得为时疫发热，又当知有浅深表之异，不辨无以施治，发热表症居多，亦有症发热，半表半发热，余邪不尽复出於表发热，邪退正虚发热，而表症发热，脉不浮不沉而数，寸大於关尺，热在皮肤，扪之烙手，久按反轻，必兼头痛，项强，腰痛，胫酸，或头面，身体，皮肤，有红肿痒痛，诸症不必全现，有一於此，便是表症发热，九味羌活汤，人叁败毒散，六神通解散选用，冬月严寒，及恶寒甚者，大青龙汤，葳蕤汤，越婢汤，阳旦汤可借用，全不恶寒者，白虎汤，黄芩汤可加减用，症发热，脉或滑，或沉数，或洪滑，关尺盛於寸，热必在肌肉筋骨，初扪热轻，久按热甚，必兼烦渴，胸腹满，大便或不通，或自利，或便血及脓，小便黄赤，或狂昏，诸症虽不必全现，必兼二三症，方是症发热，梔子豉汤，黄连解毒汤，小陷胸汤，三承气汤，导赤泻心汤，猪苓汤，天水散选用，半表半发热，脉多弦，胸胁满，或热或止，或口苦咽乾，目眩耳聋，或目赤，或喜呕心烦，或兼见表裏症，达原饮，柴葛解肌汤，小柴胡汤选用，时疫初热时，用药最要清楚，此处头绪不差，後传变多危，救援亦易，不然，难於收拾矣，凡见发热，即常辨其气，色，神，脉，舌胎，为风寒，为时疫，系时疫，又当辨在表在裏，在半表半裏，然时疫见症，纯表纯者少，表夹杂者多，表夹杂，吴氏达原饮为主，表症多，加羌活，裏症多，加大黄，半表半裏症多，加柴胡，葛根，淡豉，或表裏症均见，则诸药全用，即三消饮，取效最多，诚时疫主剂，至已愈数日而复发热者，乃募原伏有不尽之邪，复出於表，当察其证之表裏多寡，以前法治之，大抵愈後复发，则热多而表热少，虽有当用表药之症，不过葛根，柴胡，淡豉而已，无更用羌活之理，若愈後另受风寒，发热无汗，舌上无胎者，不在此例，时疫愈後，复热无汗，重用葛根五钱最妙，以其性凉，而解肌发汗，既不碍无汗之表，又不碍烦热之裏，更有平素虚损，或老人，或大病後复染时疾，屡经汗下清解，其热转甚，或全无表实证，或六脉豁豁然空，或较初起洪滑更甚，或用表药而身痛更甚，或屡用清热药而烦躁沉昏更甚，或屡用下药而舌燥更甚，此皆邪退止虚之发热也，王太仆所谓大虚有盛候，反泻含冤也，此时须略去证状，而消息阴阳虚实，阴虚，则热渴枯竭之症多，责在肾，宜六味地黄汤，兼气虚，合生脉散，须大作汤液，昼夜频进，效始捷，阳虚，则呕利悸眩之症多，责在脾，宜六君子汤，兼阴虚，归脾汤，叁胡三白散，清燥汤选用，若遇此等症，仍用汗，下，凉解，宣伐，断无生理矣，又发热之为表为，为半表半，为复为虚，症状明显有据者，自易施治，若脉症夹杂模糊，难於分辨者，须以舌胎为据，初起舌胎薄白，或无胎而润，属在表，白胎而厚，或兼微黄，或中黄边白，中黄尖白，或二三色，属在半表半，黄胎，酱色胎，黑胎属，舌胎燥，则不论何色，皆属症，屡经汗下後，舌胎润而发热者，属阳虚，无胎而燥者，属阴虚，发热之表虚实，依此辨之，思过半矣，惟虚证发热，有似实症，即舌胎亦难凭据，又当从病之

来路探讨，若屡经汗，下，宜伐而热愈甚者，从虚治无疑，或虽经汗下而热渐减，药有效，则仍属馀邪未尽，不可遽补，致邪热复壅，夭人年寿，似此虚实关头，不可不细心体认也。

以上辨表

虚实诸法，虽指发热时言，然类而推之，凡症皆可依此为辨，惟在学者之善悟耳。

恶寒时疫恶寒，与风寒暑湿诸症不同，诸症恶寒无时而势不甚，时疫恶寒有时而势甚，恶寒之後，必见发热，热时自热，而不觉寒，寒时自寒，而不觉热，非若诸症恶寒发热之相兼也，时疫恶寒，传之後少，在表之时多，而辨气，色，神，脉，舌胎，与发热同，但有浅深虚实之异，邪浅而在表者，恶寒之时少於发热，治法方药同於发热，解表为主，邪在半表半

者，寒热往来如疟状，治法方药亦同发热，邪深入，失於攻下，而热深厥深，反欲拥被向火，恶寒而不发热，或热亦微，甚则四肢反厥，此虽恶寒，实非寒也，乃阳气为邪所郁而不通，以通郁为主，达原饮，大柴胡汤，三承气汤选用，使裹气通而郁阳发，反大热而烦渴也，此证在恶寒时，最难辨其为热，须於九窍察之，如目大小眦赤，鼻孔乾，唇红，舌胎黄黑燥，耳鸣或聋，小便黄赤涩痛，大便燥结，或稀黄极臭，或鲜血，或心下至少腹有痛不可按处，此皆热深阳郁之象，大抵周身皆见冷症，一二处独见热症，反当以热症为主，反此亦然，乃辨寒热真假之机要也，余所见时疫，不下数千，症恶寒者，百中一二，即四肢厥逆，爪甲青紫，询其所苦，亦不恶寒，此可得其慨矣，至若本系时疫热症，因其人平素虚损衰老，及大病之後，用攻伐寒凉太过，至汗出不止，呕利俱作，四肢微厥，六脉细濡而恶寒，为阳虚，乃攻伐太过所致，当以叁，苓，术为主，寸口脉微者，佐以升，柴，尺脉微者，佐以桂，附，须知虽属阳虚，却从热症来，而阴必亏，桂，附亦不可过用，当佐以护阴药为妙，如白芍，麦冬，五味之类，此症温补略缓，及温补不到，必死，或过用温补，阳虽回而阴竭，亦死，此处不可不斟酌至当，又有宣伐太过而成虚症之恶寒，寒凉太早而成实症之恶寒，以疫邪方伏於募原，未经传变之时，胸膈必多痰滞，有见其烦躁而遽用知，膏，芩，连者，有因其作渴而遽用生地，麦冬者，有病者自认火症而恣啖冷水西瓜梨 太早者，皆能抑郁阳气，壅闭邪热，热遏於中下二焦，冷物停痰滞於上焦，每每见恶寒症，遇此惟以宣导痰滞为主，痰滞通，则恶寒自止，不可过温，致下焦瘀热，畜血斑黄呃逆而死，不可清凉，致胸腹痞闷而危，宜用草果，厚朴，槟榔，木香，半夏，苍术，莱菔，苓，泽，导痰开滞逐水，痰滞水去，则恶寒止而热症见，随其传变，以施凉解攻利之剂，乃有效也，此法特救药误，非治正病耳，总之风寒以恶寒为重，时疫以恶寒为轻，多有初起恶寒，一二日不治，邪气传变而恶寒自己者，与其误治，毋甯俟之，若误认恶寒为真寒，用辛温之药发散，未有不增其病势者也。

寒热往来寒热往来，与发热恶寒异，发热恶寒，一时兼至，寒热往来，寒已方热，热已方寒，亦与疟不同，疟发有时，寒热长短有定，此则寒热无时，长短无定，虽

不同於疟，而邪俱在少阳半表半 之间，在传变之初，是由轻入重，始则寒热往来，继则热多寒少，再则但热不寒，至昼夜壮热，烦渴毕现，在传变之後，是由重出轻，昼夜壮热，渐减而为发热，有时而止，又减而为寒热往来，又减而为战汗，至脉静身凉而愈，夹疫邪，自 出表者轻，日表入者重，初起寒热往来，是自表入，犯及少阳，裹气与邪相争拒，继则邪深入，表 并而为热，昼夜壮热，而势日重，既传变之後，而寒热往来，是邪气向衰，正气来复，自 出表，经过少阳，前之昼夜壮热邪气秉纲者，至此正气渐和而寒热有时矣，前之邪阳独盛亢极无阴作纯热者，至此则阴气来复而寒热相争矣，前之邪并表裹而热渴日加者，至此则裹气逐出表邪而作战汗矣，治法於未传变之先，欲由表入 时，但透达其邪，使易传化为主，达原饮是也，於传变之後，欲自 出表时，以和解为主，小柴胡汤是也，於屡经汗下之馀，脉或虚微濡弱结代，心或悸动，神或委倦，形或羸弱过甚，当养阴益气，助正却邪为主，叁胡三白汤，炙甘草汤，清燥养荣汤，补中益气汤是也。

头痛时疫头痛，与风寒不同，风寒是寒束於上部，中下无邪上逆，头虽甚痛，而不昏闷，时疫是热蒸於上部，中焦邪犯上焦，头不甚痛而昏闷，所谓卓然而痛者是也，验得气，色，神，脉，舌胎为时疫头痛，而又有表 之分，初起头痛，脑後，巅顶，目珠略甚，舌胎白而发热者，太阳头痛，以羌活，川芎为主，淡豉，酒芩，知母，生地为辅，额颅胀痛，目痛鼻孔乾，舌胎白而微黄，烦热而渴者，阳明头痛也，葛根为主，淡豉，石膏为辅，两额角痛，眉棱骨痛，寒热往来，口苦咽乾，舌胎中黄边白，或中段黄尖上白，少阳头痛也，柴胡，荆芥，川芎为主，酒芩，石膏为辅，头痛而三阳症悉具者，吴氏三消饮为主，时疫头痛，专见一经症者少，杂见二三经症者多，此方尤为多效，头痛甚者，加淡豉，荆，防，消其头目，头痛，舌胎黄，心下满，蒸蒸发热者，阳明 症也，三黄石膏汤，小承气汤，大柴胡汤，防风通圣散选用，舌胎黄，或半截或傍边有小块白，胸满而呕，头痛兼眩者，痰厥头痛也，前胡为主，半夏，莱菔子，枳，橘，山查，麦芽为辅，兼烦热者，加大黄，枳实，汗下清解後，头痛心悸，四物汤去川芎，加丹皮，知母，黄柏，或归脾汤，逍遥散并加生地，枣仁，凡头痛见症混杂，难分表 者，总以舌胎辨之。

头眩时疫头眩有三，其一，风热头眩，乃时疫本病，寸日脉多浮而尺热，荆，防，芎，薄，天麻为主，黄芩为辅，烦渴加石膏，其一，夹水头眩，乃时疫兼症，脉沉而弦滑，兼呕胸胁满悸动，前胡为主，半夏，茯苓，枳，橘，胆星，莱菔，苏子为辅，然必视时疫大势，属表属 ，於应用本方中加此数味可也，其一，虚症头，乃时疫变症，多见於汗下清解後，或素有怯证者，如上虚，寸口脉不及关尺，多汗，少气不足以息，心悸，叁， 为主，中虚，关脉不及寸尺，多从呕利太过而来，不思食，苓、术为主，下虚，尺脉不及寸关，腰膝痿厥，二便清滑，六味地黄为主，三虚皆可加天麻，或虚证已见，仍夹有邪疫燥热，则不妨兼用清热之品，或补後脉气稍实，再为清解亦可，大抵时疫头，多属热，少属虚，治须斟酌，若伤寒亡阳头，又当遵仲景法治之。

头胀时疫头胀者，乃胃热上蒸也，下之则愈，兼表者，防风通圣散，大柴胡汤，吴氏三消饮，无表症者，三承气汤选用，病虚胀，与头眩参看。

头重时疫头重者，湿热上雍也，与清凉解表药中加苍，或利水药，病後虚重，亦与头眩参看，又有表

无病，病在头中者，其目必黄，当遵仲景法，用瓜蒂散搐鼻出黄水即愈。

目胀时疫目珠胀者，阳明经病也，兼表症，葛根葱白汤加石膏，若胸满舌有黄胎，宿食也，盖食壅阳明，其脉不下行而上逆，故目珠胀，宜平胃散加山楂，麦芽，枳壳，消导之则愈，至屡经清解而目珠胀痛不愈者，当消息其肝脏，以养阴滋血和肝之法治之，如再不愈，则当进而滋肾，乃乙癸同源之治也。

项强酸时疫初起，项强酸，兼发热，乃邪越於太阳经也，羌活为主，狂躁正盛而项强者，热壅其经脉也，石膏，黄芩为主，屡经汗下，发热已退而复项强者，血燥而经无养也，四物六味为主，外此若伤寒发痉之项强，亡阳漏风之项强，则又有仲景之法在。

背痛酸时疫初起，背痛兼发热者，邪浮於太阳也，羌活为主，背痛而胀，兼胸胁胀者，邪客募原也，草果、厚朴、槟榔、莱菔子，大腹皮为主，屡经汗下後，发热已退，背痛不止者，经脉血亡也，六味生脉，四物为主，又有平素劳倦内伤而背痛在膏肓二穴者，当於东垣内伤诸论察之。

腰痛酸时疫初起，腰痛兼发热者，太阳受病也，独活为主，兼胀者，气滞也，加槟榔，兼重者，夹湿也，加苍术，牵引少腹及两胁者，气滞血瘀也，加青皮、乌药、赤芍、元胡，兼理气血，疏通肾肝，此皆初起实症治法，又有即夹肾虚阴伤者，腰痛独甚於周身，兼酸痿无力，若尺脉无力，後来传变必危，当於初起在表时，加入人参、知母、生地预顾其阴，则危殆差减，若徒用伐邪之品，邪之深入者未必去，而阴液大伤，则沉昏舌黑直视失尿诸症见，阴伤气脱，则厥逆症见，盖腰乃肾府，为先天根本，腰痛则肾虚，不可不察，要知此时疫初起，腰痛尚有虚实之分，若汗下後而见腰痛，其为肾虚，不待言矣，宜六味，四物，不可疏通。

膝痛酸时疫初起，膝痛发热者，邪在太阳经也，独活、槟榔、牛膝为主，兼软者，湿甚也，苍术为主，然此特太阳之一症，初起以解表邪大势为先，膝痛专药，一二味而已，若经汗下，表邪大势已解，则当察其邪气之有无，正气之虚实专治下部，不然，恐致残废，倘余邪不尽，留於下部，则仍有热症，如骨蒸、小便黄赤，以黄柏、苡仁清湿热，槟榔、木通通壅滞，筋挛，则秦艽、木瓜，筋缓，则苍术、防己，红肿，则赤芍、丹皮、续断、芎、归，若无余邪，见心悸，二便频数，尺脉虚小，则当以补肾为急，六味加牛膝、枸杞、知、蘘，滋益阴精。

胫腿痛酸时疫初起，胫痛酸者，太阳经脉之郁也，独活为主，兼挛者，治在筋，加秦艽、木瓜，兼肿者，治在肉，加木通，赤芍，槟榔，兼软者，属湿温，俗名软脚瘟，往往一二日即死，宜白虎加苍术汤，或苍术，黄柏，此与膝痛颇同，未经汗下，则解表之大势加一二味胫痛专药，表症已解，惟留此症，当专治之，若屡经汗下而见虚症，亦以补肾为主。

足痛时疫初起足痛，有因素有脚气痼疾者，但治时疫，於解表药中微加槟榔，木通，若已汗下，表俱平而足痛不愈，则消息其肾家虚实，同膝胫痛法治之。

肩臂痛酸时疫初起，肩臂痛酸者，手太阳经脉受邪也，解表，则痛自己，经汗下後而肩臂痛者，有经隧阻滞，血脉空虚之故，经隧阻滞者，脉多有力，证多热渴，以清热活血为主，黄芩、赤芍、归尾、红花之类，血脉空虚者，证多痿困，脉多虚涩，养血益气为主，四物合叁， 之类。

腕痛时疫初起腕痛者，乃风淫末疾也，初起，解表，汗下後，益气养血，与肩臂痛同治。

周身骨节酸痛项背腰膝胫足肩臂诸痛，已列於前，则周身之酸痛备入，兹复列周身骨节酸痛者，以痛在一处，邪有专注，痛若周身，邪有分布也，专注之邪，须通其凝泣，分布之邪，须解其缚束，故治周身酸痛，疏表其大法也，而酸与痛亦有别，酸轻而浅，痛重而深，酸痛与拘挛又有别，酸痛与重加常，拘挛屈伸不利，酸痛病在营卫，拘挛病在筋骨，合酸痛拘挛，又有上下浅深前後之不同，在身半以上，为末疾，浅而易解，在身半以下，为本病，深而难，合上下之酸痛拘挛，在未经汗下与已经汗下者，又有别，未经汗下，属邪盛，宜宣伐，已经汗下，属正虚，宜调补，明乎此，则酸痛在周身，在一处，按症施治，无不当矣，解表诸方，人叁败毒散，九味羌活汤，六神通解散，大羌活汤。

身重时疫初起，发热身重者，湿胜於热也，苍术为主，二三日或四五日，传变之後，汗出更热而身重者，热壅其经脉也，白虎汤为主，传，表无热，而舌燥便秘，腹痛拒按，而身重者，内结而气不达於表也，三承气为主，屡经汗下，表热已退，身重不可移动，脉虚散而无根，舌上无胎，二便自通者，阴阳两亡，经脉枯竭也，审其阴阳偏胜而治之，偏於亡阴，多燥症，六味合四物为主，偏於亡阳，多脾虚症，六君合生脉为主，阴阳俱竭，生脉合六味为主。

自汗时疫自内蒸出於表，初起作寒热时，多自汗，甚至淋漓不止，不可以表虚论，兼头痛身痛，仍以解表为主，羌，独，柴，葛之类，兼烦渴，直清阳明之热为主，白虎之类，有热有结，破结为主，陷胸，三承气之类，若屡经汗下，邪已全退，脉虚而舌无胎，二便清利如常，内外无热症，方可从虚敛汗，盖以时疫得汗，为邪有出路，而宜敛汗者，恒少也。

盗汗时疫初起盗汗者，邪在半表半里也，胸胁痞闷，达原饮，无痞闷，小柴胡汤，汗下後，大热已退，有盗汗者，馀邪不尽也，小承气，小陷胸，吴氏承气，养荣汤诸方，清其伏匿馀邪，盗汗自止。

战汗时疫不论初起传变未後，俱以战汗为佳兆，以战则邪正相争，汗则正逐邪出，然有透与不透之分，凡透者，汗必淋漓，汗後身凉，口不渴，舌胎净，二便清，胸腹胁无阻滞结痛，始为全解之战汗，否则馀邪未净而复热，则有再作战汗而解者，有战汗须三四次而後解者，有战汗一次不能再战，待屡下而退者，有不能再作战汗，再加沉困而死者，总视其本气之强弱何如耳，凡战汗之时，不可服药，补则战止而汗不透，留邪为患，汗下则太过而成虚脱，应听战汗透彻，再观脉症施治，当战时，或多与热汤饮之，助其作汗，战汗之时，脉多停止，勿讶，待战汗之後，脉自见也，大抵战汗之脉，以浮为佳，邪出於表也，虚散微濡应有变，煎独叁汤以待之，防其脱也，贫者米饮聊代之，然必察其战後系邪净而气欲脱方可用，凡战汗後，神静者吉，昏躁者危，气细者吉，气粗而短者危，舌痿不能言者死，目眶陷者死，目转运者死，戴眼反折者死，形体不仁，水浆不下者死，战汗虽为佳兆，亦有吉凶，得战汗固由治得其宜，邪退正复而致，然不可强也，尝见服大发汗药，毫不得汗，而饮冷水得汗者，又有用下药得战汗者，凉血活血得战汗者，生津益气得战汗者，种种不一，当知战汗乃阴阳交和，表里通达，自然而然，非可强致也。

狂汗时疫临解，有忽手舞足蹈，跳床投掷，而後作汗者，最为骇人，然须验其是否作汗，作汗之脉浮而缓，浮为邪还於表，缓则胃气自和，待汗透自愈，脉若浮洪，浮数，浮滑，浮散，虽有汗，亦为发狂，非作汗也。

头肿时疫头肿，乃风热壅於上部，太阳之经脉，郁滞巅顶，俗名大头伤寒，常视表轻重，加轻清疏风之品以散其肿，荆，防，薄荷，蝉退，川芎，蔓荆，菊花之类，如发热舌胎白，表重於里也，合表药用九味羌活汤，人参败毒散是也，如烦渴舌胎黄者，里重於表也，合药用三消饮，凉膈散，大柴胡汤，调胃承气汤是也，古有用三棱针刺出恶血，法亦可用，至发痈脓者，不在此例。

面肿时疫面肿，风热溢於上部，阳明之经脉被郁也，赤肿者方是，治以白芷，防风，葛根，石膏，散其风热，视表里之轻重，合头肿条内诸方加减用之，若黄肿，乃水气也，当从水肿治之。

颈项肿时疫颈项肿，乃阳明风热，俗名捻头瘟，又名虾蟆瘟，当按头肿条内表里诸方加葛根，桔梗，牛蒡，防风，玄叁，痈脓发颐，不在此例。

耳旁肿时疫耳旁肿，乃少阳风热，俗名黄耳伤寒，小柴胡汤加荆，防，芎，芍，元叁，亦当与头肿叁看。

胸红肿时疫胸前一片红肿，粟起似麻疹，风热也，俗名赤膈伤寒，亦於头而诸条表裏方中加荆，防，连翘，赤芍，牛旁，土贝。

周身红肿时疫周身红肿，风热流於皮肤也，用羌，独，升，柴，葛，芷，疏其皮肤之毛窍，石膏，黄芩，梔子，连翘，清其肌肉之热，赤芍，归尾，红花，生地，活其毒热之瘀，兼 症与头肿诸条叁治。

以上头肿诸条，列之表症者，以初起言之，若见於病後，曾经汗下者，为餘邪不尽，治法则小异，大约见於初起，表邪盛实，用表散之药为主，清之药为辅，见於病後，邪留溢，用清之药为主，表散之药为辅，以此为权衡，思过半矣。

发黄时疫发黄有四，一宿食，二蓄水，三畜血，四郁热，当疫症初转在表时，胸膈痞闷，目珠黄，面鼻正中黄，宿食壅於胃也，於表药中加山楂，神僭，麦芽，莱菔子，传 时，小便不利，腹满而响，面目身俱黄，蓄水也，四苓散加梔子，茵陈，胸腹有软痛处，小便自利，大便黑而发黄者，畜血也，桃仁承气汤，热在下焦，大小便俱不利而发黄者，郁热也，茵陈蒿汤，凡发黄必以二便为辨，二便调，属上焦，小便不利，属水，小便自利而大便黑润，属血，大小便俱不利，属热郁，乃胃热移於膀胱，不必利其小便，但当通其大便，是以茵陈汤有专功也，发黄当辨其色，上焦宿食发黄，只在面目，不及周身，蓄水发黄，周於身，兼微黑而黯淡，瘀血发黄，亦兼微黑而润泽，郁热发黄，兼赤而鲜明，此即以黄辨黄之法也。

发疹时疫发疹，热邪从皮毛出也，与汗同机，以疏散清热为主，然与他症发疹不同，他症或无裏热，此则未有不 热者，虽以疏散为要，而见烦渴舌胎黄，则硝黄仍须兼用，表症发疹，疹散而病即愈，此则有屡发而病不衰者，他病发疹，不过一二日为期，此则为期不定，治法不视表邪解否为用药之准则，不可以疹之一症为据也。

发斑时疫发斑，邪热出於经脉也，虽不及战汗，亦有外解之机，治以凉血清热为主，白虎化斑汤，吴氏举斑汤，犀角地黄汤选用，此亦与他症发斑有异，他症发斑，斑消则愈，此总不以斑之消否为轻重，而惟以症为主，每每斑出，而如故，或斑出数日已消，而沉昏如故，必待 热全清，二便清利而後愈，故治斑药味，可为辅，不可为主，发斑发疹，热皆在经而不在胃，凡遇烦躁而不渴，日赤而舌白，即是将发斑疹之候，预以清凉解表透毒之药治之，使邪易出而病易净。以上时疫表症，皆关乎 ，不似他症，表 两不相关，故前列各条皆冠以时疫二字，以明非他病之见症，不可以治他病之法治之，亦不可以此法治他病，总凭气，色，神，脉，舌胎辨之，百不失一，是五者为辨时疫之大纲，实亦辨时疫之细目也。

广瘟疫论卷之三

里证

烦躁

烦乃心烦，情思不定，神不安而形如故，躁则形扰，扬手掷足，形不宁而神复乱，烦轻而躁重也，在他证有谓烦属心躁属肾者，烦属阳躁属阴者，在时疫总属郁热，热浅在上，则见烦躁之形，热深在下，则渐近昏沉而不烦躁，是时疫初起，可即烦躁之轻重，辨病势传变之轻重，不烦躁则非时疫，设气，色，神，脉，舌胎有时疫确据，亦属但表不 之轻症，凡初起憎寒发热而烦躁者，邪在半表半 ，三消饮，九味羌活汤，六神通解散选用，隆冬寒甚，汗难出者大青龙汤，葳蕤汤可借用，舌胎已黄，渴而喜饮，身热汗出而烦躁者，邪入於胃也，白虎，黄芩，三承气，小陷胸，三黄泻心，凉膈散选用，舌胎已黑，烦躁渐近沉昏者，邪入心包也，犀角地黄汤加羚羊角，黄连解毒汤选用，屡经汗下清凉，表 俱无阻滞而烦躁者，阴液伤也，生脉散，六味地黄汤，吴氏诸养荣汤选用，或用清解清利滋润诸法不应，而烦躁加甚者，当细验舌胎，色黄黑胎中夹一块白润，是为夹水，或平素胸有痰饮，或未病之先曾饮冷物，或初烦躁时过饮冷水恣啖凉物，或用清凉太早，皆能停饮於胸膈胃 之间，寒饮拂郁，其疫热外不能达表，内不能传胃，故烦躁转甚，验舌之後更细按胸胁，满痛而软，漉漉有声，再细察其脉，右寸关或弦紧或缓，皆停水确据，当以苍术，半夏，莱菔，厚朴，先消其水气，然後治其烦躁，无不应者，不论舌胎有无黄黑，但烦躁而兼小便不利者，虽无水气在胸胁，而少腹略有满痛处，即当以导赤泻心汤，四苓汤，猪苓汤，益元散利其小便，所谓心邪不从心泻而从小肠泻也。

呕

吴又可曰，时疫有始终能食者，邪不传胃也，慎勿绝其饮食，此不呕者也，愚尝见时疫初起，未发热时，表症未见，有先作呕数日者，此疫邪先犯太阴，当辨其口气，无臭气而不粘者，属太阴寒症，有臭气粘厚者，属大阴疫症，此为先裹而後表，不可遽用清凉闭遏邪气，致使不能透达传化，虽四肢有时厥逆，脉有时沉伏，亦不可用温热，致增呕症，甚有舌紫，沉昏者，惟当宣其胃气，藿香正气散最宜，若已发热而呕者，吴氏达原饮加半夏，若三阳表症，加羌活，葛根，柴胡，若呕而烦渴，身热而不见寒者，邪在阳明也，白虎汤，黄芩汤，并加半夏，若呕而舌黄，胸中有满痛处，橘皮半夏汤，加枳实，山楂，麦芽，川贝，贝母力缓，用至五钱或一两乃能舒郁散结，若呕而舌黄，心下脐上有满痛拒按者，大柴胡汤，若呕而舌黄或黑，少腹有满痛拒按，当视其前後何部不利，大便不利，调胃承气汤，小便不利，四苓加木通，或益元散，利之则愈，寒热已解，二便通利，胸腹无滞而呕不止者，馀热在胃也，竹叶石膏汤，屡经清下，倦怠异常，四肢渐冷者，乃清下太过而中寒也。

，理中汤，甚至加附子，然此为治药之法，非治疫之法也，宜详察之。

咳

咳者，疫邪夹他邪干肺也，有初起在表，夹风邪干肺者，脉兼浮，多痰沫，必兼鼻鸣自汗，洒淅恶寒，於透表诸方中加前胡，桔梗，苏子，杏仁，淡豉，有夹水干肺者，不论表裏，脉必兼缓，必多清痰，兼舌白心悸胸满，或呕或吞酸，於表药中加桑皮，半夏，茯苓，川贝母，莱菔子，有疫热传裏，燥火肺者，脉必数，必无痰，有痰亦难出而咽痛，於药中加花粉，黄芩，川贝，薤仁，有病後阴伤肺燥者，脉必涩，必无力，舌必赤而无胎，吴氏清燥养荣汤加麦冬，玄参，知母，贝母，有屡经汗下，或平素阴虚肾气上逆者，必兼上气，颧必时赤，足膝必清痿，脉必散，六味加枸杞，五味，牛膝，疫邪兼者少，即有之，亦非大有关系之症，宜以病之表裏大势为主，加治药於本方疗之。

渴

渴乃热象，时疫为热症而有不渴者，盖初起湿热相兼为蒸气，热未胜湿，则郁闷心烦而不渴，热已大盛，在经而不在胃，则烦躁身热而不渴，在下而不在上，则便结而不渴，在血分不在气分，则沉昏而不渴，疫邪初起在阴发者，胸腹满呕而不渴，此外无有不渴者矣，初起在表，发热头痛舌白而渴，脉必不浮不沉而数，六神通解散加石膏，葛根，或九味羌活汤加石膏，葛根，半表半裏，口苦咽乾目胀而渴，脉必数，小柴胡汤加花粉，知母，或亦加石膏，或达原饮加石膏，葛根，邪已入胃作渴，身热自汗，舌现黄胎，或酱色，或黑燥，当察其胸胁少腹，按之无痛点而渴者，为有热无结，脉必洪，宜白虎汤，按之有痛点，为有热有结，痛在心下，脉必滑大，关上尤甚，小陷胸汤，在脐上及当脐，关中脉必滑大，小承气汤，在脐下，尺中脉必滑大，调胃承气汤，心下至少腹俱痛，寸关尺必皆滑大，大承气汤，痛在左肋不可按，左关脉必弦，或涩，或芤，桃仁承气汤，痛在右肋不可按，右关脉必弦，或滑，或迟，十枣汤，渴而小便不利，少腹不可按，尺脉必数，四苓汤，猪苓汤，六一散，汗下後，身热已除而渴不止，馀邪未尽也，宜将前所用药再作小剂以利之，屡经汗下，渴而舌上无胎，胸腹无满痛，心悸而烦，脉虚细，或浮芤，或涩，亡阴也，六味合生脉为主，渴与烦躁同机，而渴轻於躁，渴有喜饮不喜饮，而又有喜热饮冷饮之分，在他症不喜饮及喜热饮，则为真寒假热，在时疫喜热饮，多发斑疹，不喜饮者，热在血分，若真寒假热，百不一见也，时疫初起，以渴为机括，渴甚则热甚，渴微则热微，在末路，尤以渴为有馀邪，不渴为无馀邪也。

口苦

热邪在中上二焦则口苦，非特时疫而然，即感风寒口苦，亦属少阳热症，如时疫当恶寒发热表症正盛时，苦见口苦，即於发表药中倍加清热之品，轻则黄芩，重则知母，再重则石膏，不但三阳表症如此，即三阴裏症，手足冷，恶寒，呕利，胸腹满，不渴，证状似乎纯冷无热，而一兼口苦，即当於温燥药中加利热之品，如用半夏，苍术，草果，厚朴，必加木通，苓，泽，甚至加知母，黄芩，本吴氏达原之义，口苦为热症的据，每遇症状模糊，寒热莫辨，必借此以决之，至舌胎黄黑乾燥，烦躁热渴闭结，又清下之不可或缓者矣。

口甘

口苦口甘，同为热证，苦为燥热，在上中二焦，多渴，属三阳，甘为湿热，在中下二焦，多不渴，属三阴，盖脾胃属土，稼穡作甘，土邪下涉肾位，水土相蒸，甘味上溢於口，多兼呕吐，人每误认胃寒而用温中之剂，不知湿热在於下焦，土能克水，温燥太过，肾水告竭，总不见热渴诸症，惟目不见物，渐至昏沉而死，口甘一症，在诸症初起，犹可用温燥开导之品，而亦不宜过剂，在时疫必以清热为主，消痰为辅，或胸中停饮太甚，亦不过加苍术，半夏而已，如二陈去甘草加姜汁炒山栀，姜汁炒黄连，竹茹，黄芩等类，为口甘要药，乌梅更妙，酸能胜甘，盖五行克制，自然之理也，或四苓散加山栀亦得，然必以时疫之大势，为用药之权衡，斯可矣。

唇燥

唇燥者，阳明热也，时疫见此，当辨其色，深赤为大热，宜清下，淡白为亡津液，宜滋润，色如常，为津液不流通，热在经脉，宜葛根。

齿燥

时疫齿燥有三，轻浅者为阳明经热，前板齿燥，身热目疼，鼻乾不得卧，此将发斑疹及衄血之先兆，葛根为主，黄芩，知母，石膏为辅，重者为胃府燥热，通口皆燥，甚则黑如煤炭，三承气，三黄石膏选用，重者为阴火煎熬，亡血太甚，肾水涸竭，当峻补其阴，知母，黄柏，生地，元叁，天冬，麦冬，丹皮，每味两许，大作汤液，加童便，金汁，昼夜兼进，若药轻治缓，则不及矣。

鼻孔乾

时疫鼻孔乾有四，风热，则鼻鸣，荆防，葛根，薄荷为主，阳明经热，则烦躁，葛根，石膏为主，胃热府症，则大渴舌黄，三黄石膏为主，亡津液，肺燥，麦冬，生地，五味为主，大抵风热经热者十之五六，府热亡液者十之二三，非谓热深而鼻孔反不乾也，以烦渴大热症见，则不觉鼻孔之乾与否耳。

耳聋

耳聋者少阳邪热夹痰上壅也，时疫耳聋者多，盖邪之传变，出表入里，必干少阳，又时疫属热，热主上升，挟痰涎浊气，上壅隧道，故耳聋也，治法以疫邪大势为主，见於初起传表时，於表药中加荆，防，川芎，见於入裏时，於药中加黄芩，知母，屡汗汗下，耳聋不愈，不可急治，养阴调胃为主，须待粥食如常，二便调匀，始由渐而愈也。

鼻如烟煤

时疫鼻如烟煤者，邪热烁肺也，由鼻孔乾而来，急当清下，少缓则肺胃枯绝矣，三承气合白虎，或三黄石膏加青黛，或小陷胸加犀角，或犀角大青汤，视其兼症，择而用之。

鼻孔扇张

鼻孔扇张有三，一痰壅於肺，气出入有声，喘胸满，不渴，宜瓜蒌，贝母，桑皮，苏子泻肺，肺气通自愈，一郁热於肺，气出入多热，有微表束其郁热，古人独主越婢汤，盖散其外束，清其内郁也，用於时疫中，以葛根易麻黄，或葛根黄芩黄连汤亦可，一肾气虚而上逆，气出人皆微，多死，此证必得之屡经汗下，或兼多汗，心悸耳聋，急宜大剂六味合生脉散，加牛膝，枸杞，或可百救一二。

咽乾

咽乾者邪热淫於膈上也，在伤寒为少阳热证，时疫亦然，宜黄芩，甚则佐以花粉，知母。

咽痛

时疫咽痛，为热淫於肺，当视其咽中有结无结，无结者微红，以桔梗，花粉，黄芩，元参治之，有结者红肿，当加牛蒡，恭芍，消其肿，结甚则起紫泡白泡，是为乳蛾，必以针刺去恶血，再服清热之药方妙，时疫中常有急喉风，急喉痹二险症，旦发夕死，不可不察也，急喉风咽痛而喘，乃痰邪夹热上壅於肺，古方用胆矾吐其痰涎恶血，或皂角膏吐之，治之稍缓，则气闭而死，急喉痹即乳蛾速长，闭塞喉咙，亦以刺去恶血为主，甚或用刀大开其脓血，此虽见於时疫中，必其人平素贪厚味，多怒郁，肝火妄动，有以致之也。

舌燥

舌乃心苗，肾窍通其本，脾脉络其下，时疫舌燥，由火炎土燥，中宫堵截，肾水不能上交心火，须察其胎之有无，与色之深浅施治，白胎而燥，疫邪在表，痰已结於膈上，吴氏达原饮加石膏，川贝，菱仁，大黄，此吴氏名白沙胎，热极不变黄色，下之即黄，不可缓也，黄色而燥，疫邪传胃，小承气，小陷胸，大柴胡选用，酱色胎而燥，疫邪入胃，深及中下二焦，调胃承气汤，黑胎而燥，疫邪入胃至深，伤及下焦，大承气汤，燥成块裂，或生芒刺，热更甚也，大承气倍其分两，大黄须两许方妙，各燥胎，下之渐减，不即尽净，为药已中病，力未到耳，当再下之，有下至三五次十馀次而後愈者，若屡下而燥胎愈长，不可更下，当察其腹中，若揉按作响者，痰水结於中焦，脾胃受困，津液不能上潮，改用平胃，二陈温燥之剂即愈，又肾阴竭涸，愈下愈亡其阴，燥胎不回，目无神，耳聋，心悸，腰痠，再下必死，宜六味地黄汤合出脉散，至无胎而烦，须辨其色，正赤或深紫，热归心包，血分热极，石膏，知母，黄连，犀角，羚羊角，牛黄为主，鲜红亡阴，二冬，生地，元叁，知母，阿胶，人叁为主，大抵舌无胎，则胃无物，可清润，不可攻下。

舌强┐附舌痿

时疫舌本强硬，为热而兼痰，宜清下无疑，须加消痰之药，兼白胎者，隔间未经煎熬，其痰尚湿，佐以半夏，大柴胡汤是也，兼黄胎者，已经煎熬，其痰渐燥，佐卧川贝，枯萎，小陷胸汤是也，兼黑胎者，热极，痰亦为火，佐以牛黄方效，若无痰，舌色正赤，深紫裂燥而强者，热毒蕴於心包也，三黄石膏汤加犀角，牛黄，急清其热，舌强虽与舌燥相类，而燥属胃主热，强属心主痰，又舌痿软而枯小，与舌强硬而不缩有异，乃虚脱已极，大补及滋润，或百救一二，若屡经汗下消热消痰而舌强者，又当与舌痿同治。

舌卷短

时疫之舌，一见黄胎，便当下，失下，则由黄而变酱色，变燥，变黑，变生芒刺，再失下，则变卷，变短，为下证至急之际，宜大下屡下方和，缓则不救。

胸满痛

时疫胸满而不痛者，为邪未结，为无形之气，稀薄之痰，痛而不满者，为病在经络，有虚有实，有虚实相兼，满而痛者，为邪已结，须分痰食血以施治，属无形之气者按之不痛，时疫初起，邪在募原，多有此症，宜达原饮加枳，桔，木香，大腹皮以开豁之，属稀薄之痰者，时疫二三日，邪在半表半里，多有此症，宜达原饮加半夏，莱菔子，或小柴胡汤加莱菔子，病在经络，痛而不满者，初起属实，於解表药中加延胡，乌药，舒其经络之气血，病久屡经汗下多虚，於养气血药中倍当归，更有虚中夹实者，於解表清药中加乳香，没药最妙，满而痛不可按，邪已结矣，痰结者，牵引串痛，兼呕，小陷胸汤，大柴胡汤，或二方合用，甚则大陷胸汤，大陷

胸圆，食结者，硬痛成块不可按，多在心下，宜平胃散加枳实，苏子，莱菔子，白芥子，亦有在膈上者，为危症，当吐之，宜瓜蒂散，此二者，不可便下，须待其转动，方可下之，盖结在上焦，属气分，下之太急，则气逆呕吐，外用按揉之法为妙，血结者不可按，按之软，脉乳涩弦，宜於解表清药中加桃仁，红花，三七，归尾，甚则桃仁承气汤，时疫多实多热，至胸膈满痛，又属实邪，非虚症，惟是屡经攻下，胸痛更甚者，乃脾肾两虚，下气上逆，宜温理脾胃，以建中镇安之，甚则导火归元，纳气归肾皆可，然不多见，须消息斟酌，不可轻试。

胁满痛

胁满痛与胸满痛同，而微有不同者，胸满痛有宿食为病，胸满痛无宿食为病，乃亦有因宿食在胸，而满痛及胁者，时疫胁满痛，是痰气血三者为病，其中亦有满而不痛，痛而不满，满痛并作之分，其满而不痛者，募原之邪，未经传变，宜达原饮，兼寒热往来者，大柴胡汤，痛而不满者，邪分布於少阳之经，宜小柴胡汤，满痛并作者，当分左右，左属血，小柴胡去人参加延胡，归尾，红花，桃仁，甚者加莪术，三棱，三七，五灵脂，右属痰与气，痰则大柴胡汤倍半夏，加牡砺，莱菔子，甚则白芥子，甘遂，大戟，莞花，气则加青皮，莱菔子，木香，大腹皮，痰与气痛，皆无常所，而有聚散，痰散，仍有所苦，气散，则无所苦，若屡经汗下清利而胁痛更甚者，虚证也，气虚必呕利，养气为主，血虚必烦热，养血为主，此亦十中一二，胁痛与胸腹痛不同，胸腹譬之冲衢，塞不能久，胁则譬之僻巷，塞则难开，用药须明此意，时疫胁痛，虽有痰气血之殊，而总不离乎热，黄芩是为主药，若别有热者，黄连，山栀，又所必需，他病胁痛，有寒有热，不在此例。

腹满痛

时疫腹满痛属宿食，为邪热所结者十之七八，属气血痰水者十之二三，盖腹为胃典小肠之正界，非胸胁少腹之地可比，腹满而不痛者，属邪在气分，属水谷散漫而未燥结，气分脉多沉或弦，水谷脉滑，气分通腹皆满，水谷满有分界，气分者，厚朴，大腹皮，青皮，陈皮，枳桔为主，水谷者，半夏，山查，麦芽，神面，莱菔子，枳实为主，时疫为热症，腹满亦当清热，兼以顺气消食可也，若舌多黄胎，虽满而不痛，为邪已传胃，宜小承气汤下之，痛而不满者，属邪在血分，属水谷燥结诸病，他病或有属冷者，时疫总属热症，痛不可按而无硬处者，於清方中加赤芍，不可按而有硬处者，调胃承气汤，满痛兼作，为痞满在气，燥实在血，大实大热之症，大承气汤，诸病腹满痛，或兼自利，当责之虚冷，时疫自利，属热结旁流，下之则止，不可疑为虚冷，若满痛而喜燥喜温，或恶寒手足冷，清利之益甚，或右关迟紧，此非本病，乃因烦渴饮冷太过，或用清凉太过，太早之所致，又当以温燥为主，不可执一，然此亦治药弊，非治本病也。

少腹满痛

时疫少腹满痛，为邪热结於下焦，下焦乃大肠膀胱及厥阴分界，与中焦异，亦有满而不痛，痛而不满，满痛兼作之不同，初起满而不痛者，湿胜气滞也，槟榔，厚朴，苍术为要药，痛而不满者，手不可近，热伤厥阴血分也，黄芩以清热，赤芍，归尾以活血，柴胡以升厥阴之气，若牵引阴器及两胯夹缝者，加秦艽即愈，满痛兼作者，不论初起末後，当视其前後，在前小水不利，蓄水也，四苓，猪苓，益元等方选用，在後大便不利，有燥矢也，三承气选用，小便利而大便色黑者，畜血也，抵当汤，桃仁承气汤选用，以大小便之通塞为辨，固矣，亦当细察其满痛，如有硬块不可按者，属燥矢，满痛如鼓，不可按而却无块者，属溺畜脬中，满痛拒按而软者，属畜血，以此辨之了然矣，外有时疫末路，满而不痛，痛而不满，喜温喜按者，为虚证，当细询来路，若屡经清下太过，当消息温补以培养阴阳，不可执时疫为实邪热证而不变通也，然此亦十中一见耳。

右满痛诸症，乃时疫 症之大端，总属热邪内陷，在风寒暑湿诸门，则寒热虚实俱有，在时疫已经传变，见於烦渴燥热既显之後，其为热症易辨，若见於未经传变之先，乃疫毒郁而未发，多不渴，多不发热，甚有手足反厥冷者，依风寒治则当温，依时疫治则当清，毫厘千里，反掌生死，当於气，色，神，脉，舌胎五者，细察而详辨之。

自利

时疫自利皆热症也，其所利之物，与内虚内冷者自别，冷利之色淡白，热利之色正黄，甚有深黄酱色者，冷利稀薄，热利稠粘，虚冷利，散而不臭，热利臭而多沫，虚冷易出，热症努圉，冷利缓，热利暴注下迫而 急，此辨时疫热利与诸冷利之大概也，时疫初起，有手足厥冷，恶寒，呕吐，腹痛自利者，全似太阴寒症，辨其为疫，只在口中秽气作黏，舌上白胎粗厚，小便黄，神情烦躁，即可知其非寒中太阴，是时疫发於太阴也，烦躁轻，则藿香正气散，烦躁甚，则用达原饮，一二服後，即见三阳热症矣，此时若用温中药，转见四肢厥冷，手足青紫而死，不可不细察也，时疫初起，头疼发热而自利，九味羌活汤，传变太阳少阳合病，身热口苦，咽乾目眩而自利者，黄芩汤，兼呕加半夏，传 ，舌黄而自利者，按其心下至少腹有硬痛处，与大承气汤，无硬痛处，小承气，小陷胸，大柴胡选用，此在下其热，不必以结为主，故虽无硬痛，亦主大黄，时疫也利而小便不利，腹满而无硬块，时作肠鸣者，热在小肠膀胱而蓄水也，四苓散，猪苓汤，益元散选用，时疫自利，受补者少，至屡经清下，无表 证，自利渐至清谷而脉微细者，则六君子汤，补中益气汤，理中汤，又所当酌用也。

便血

时疫便血，热邪深入也，先当辨其血色，鲜红者清热为主，黄芩汤，三黄石膏汤，犀角地黄汤，血色紫黯成块下者，逐瘀为主，桃仁承气汤，抵当汤，须按腹胁有痛

处，用之为确，时疫便血，散晦夹涎水者，脾胃虚而脏府伤也，归脾，补中，八珍可借用，并加乌梅，时疫便血之後，多亡阴症，神昏耳聋，舌无胎而燥，身痛不可转侧之类皆是，生脉，六味加阿胶，峻补其阴，然多不救也。

便脓血

时疫便脓血，与便血有燥湿之分，便血属燥热，凉润为主，便脓血属湿热，清热兼分利为主，时疫初起，头痛发热便脓血者，即古所谓疫痢是也，不必治脓血，但解其表，表解则便数自减，决不可早施清

攻下之药，即分利清凉，亦所当慎，盖邪方在表，清邪则内陷深入，後极难治，且时疫一见便脓血，则烦渴之热势反缓，盖热随利减也，所以苦寒之品，不可浪用，惟以仓廩汤为主，详见夹痢条下，时疫传变，至半表半裏便脓血者，柴葛解肌汤加苓，泽，木通，黄芩，时疫传变入

，烦渴悉具而便脓血者，黄芩汤，葛根芩连汤选用，兼急後重腹中拒按者，加槟榔，大黄，时疫屡经攻下而便脓血滑利者，当以养中调气养血为主，清热为佐，老人虚人，亦仿此例。

大便闭

时疫属湿热，大便闭者少，间有闭者，乃平素胃阳强盛，多躁气也，夫本来阳盛，复受时疫，则湿热皆变为燥热，虽兼表症未得汗，可下，以时疫与伤寒不同，伤寒邪从表入，有表证未得汗，必不可攻

，时疫邪从内发，虽有表证，每每发表而不得汗，必待气通，而後表始得汗，所以时疫大便一闭，即有表证，亦当下之，不可逡巡也，若初起未经表散，则当用三消饮，下之为当，有表证，尚可下，则烦渴，舌胎黄黑燥裂卷短，胸腹硬痛诸症备见，更当分别轻重下之无疑，又有大便闭而屡下不通者，则必有夹邪，当审之，有夹水者，水在肠中，则不下而自利，水在胃以上，则脉多弦多缓，往往上呕而不下利，且舌白，而心下按之作响，虽用承气，不能下行，故下之不通，当先用半夏，茯苓，苍术消其水，而後下之，亦有可用大陷胸汤者，必胸上痛而手不可近，方能药兴邪敌，有夹气者，气滞於胸膈之间，主上逆而不下降，胸腹串痛而脉沉，当先以苏子，莱服子，木香，槟榔，顺其气而後下之，有气虚而屡下不通者，属老人虚人，其脉必兼无力，其色必悴，其肌肉必缓，其神必散，若下症全具，当与大承气加入参，一服而宿垢顿下，或陶氏黄龙汤，或麻仁丸叁汤下，酌以症之多寡用之，有血虚而屡下不通者，属妇人产後，癰疽溃後，或平素阴虚，及亡血，其脉必兼涩，四物，六味，生脉，及吴氏诸养荣方，麻仁丸选用，仍须蜜煎猪胆汁导之，大凡时疫，大便一闭，即当下之，然须询其有无所苦，若无所苦，下尚可缓，有所苦而下之不通，又须察有无夹邪及虚也，当下者十之五，可缓者十之三，夹邪者十之一耳，时疫如此，他病则不然，古语云，伤寒下不厌迟，时疫下不厌早，诚哉斯言也。

小便不利

时疫初起在表时，头痛发热小便不利者，热入膀胱也，益元散主之，四苓散，猪苓汤皆可用，东垣云，小便不利而渴者，热在上焦，法当淡渗，小便不利而不渴者，热在下焦，法当苦寒，此可为据，时疫传，大便闭而小便不利者，当先通大便，大便通，小便自利，此惟时疫为然，他病则否，时疫屡经汗下，小便不利者，阴竭也，为难治，知母，黄柏，生地，麦冬之类治之，或生脉六味皆可，然每至少腹如鼓而不救也，凡小便不利，日久下关不通，必反於上，往往有呕吐呃逆，涓滴不能下咽，至汤药不进者，当用敷脐法，大田螺一枚捣烂，入麝香三厘，敷脐上，帛束之即通，一见点滴，即受汤药，古法有用葱熨，及井底泥敷少腹者，俱可叁用，但不宜於阴竭之虚人耳。

小便黄赤黑

时疫未传变时，小便多如常，热一传入则黄，热甚则赤，热入血分，畜血则黑，小便可验热之有无深浅多寡，但不可以作专症，疫邪在表，小便黄，即於解表中加清凉药，邪入小便黄赤，虽手足厥冷，亦当攻逐热，疫邪已退，表俱和，小便黄赤未退，仍当清利余邪，惟小便黑者，当逐瘀清热为主，犀角地黄汤加大黄等类，有屡经汗下，清凉太过，表俱无热邪，而滑泻腹痛小便黄赤者，当理脾升阳为主，亦治药，非治病也。

小便多

时疫为湿热，小便多者甚少，传之後，或小便多者，乃胃土变为燥热也，急下之，屡经下後小便多者，气虚也，益气升阳为主，亦有肾虚而小便多者，六味地黄汤加五味子，大抵未下之先小便多者，属燥热，小便必微黄，必烦热，渴而喜饮，既下之後小便多者，属虚，气虚则不喜饮，而寸脉不及尺，浮不及沉，阴虚则喜饮，而尺脉不及寸，沉不及浮，失治日久，则变消渴，时疫小便多者如此，若夫风寒小便多，则属阳虚，不在此例。

遗尿

时疫初起遗尿者，多属三阳合病，盖邪入於阳，则阳实而阴虚，热盛於表，为之不守，又神昏於上不自知其下部之出入，故遗尿也，合之腹满身重，口不仁而面垢，仲景独主白虎汤，此症不可下，以邪方全盛，在表在经，下之则表邪内陷，故额上生汗，手足逆冷，尤不可汗，以邪本属热，汗之则愈增其热，故心愤愤，反作，惟以白虎汤清其浮越之热，若别兼燥结僂痛者，可於本汤内加大黄下之。

囊缩

时疫囊缩乃热入於厥阴也，有结有热则下，有热无结则清，热退而囊自纵矣，阴症囊缩，与时疫颇相类，以阴症囊缩，必身冷厥逆脉沉，时疫囊缩，亦身冷厥逆脉沉也，然一寒一热，自有不同，阴症囊缩，阴jing痿缩，或全缩入腹，有加妇人，时疫热厥囊缩，阴jing如常，再以兼症辨之，阴症囊缩小便清，少腹牵引痛，痛而不满，喜温按，多自利，神清不烦，时疫囊缩小便赤，少腹满而硬痛拒按，大便秘，烦而神昏。

多言

时疫多言者，之渐也，疫热蒸心之所致，治同。

谵语

谵语者热蒸心也，时疫一见，即当清热，然有经热蒸心而者，邪在三阳，表症多有之，脉浮大，头痛发热舌白者是，吴氏三消饮最当，六神通解散，九味羌活汤，防风通圣散，白虎汤，栀子豉汤皆可选用，有膈热蒸心而者，脉洪身热，汗出不恶寒反恶热，胸中无结者是，白虎汤，黄芩汤选用，有痰涎搏结，其热聚於中上二焦而者，脉弦滑，胸痛及心下痛拒按者是，小陷胸汤，大柴胡汤选用，有胃热蒸心而者，脉滑实大，舌黄，及黑，及燥，及芒刺，腹满拒按者是，三承气汤选用，轻者只用平胃散加山查，麦芽，萝卜子即效，有热入血分而畜血，血热蒸心而者，脉沉结或涩，心下至少腹凡有痛处拒按而软者是，犀角地黄汤，桃仁承气汤，抵当汤选用，有热入小肠膀胱，畜水之热上蒸心而者，脉浮数，少腹满，小便不利者是，四苓散，猪苓汤，益元散选用，以上皆实症也，至若屡经汗下清利，二便已清利，胸腹无阻滞，六脉虚散结代微弱而者，阴阳两虚，神无所倚也，虚在上焦，必心悸神倦，生脉散加枣仁，天王补心丹，虚在中焦，必面色痿黄，四肢倦怠，归脾汤，虚在下焦，必耳聋目直视，六味地黄汤加远志，五味，龙骨，茯神。

狂

时疫发狂者，之甚者也，亦疫热蒸心之所致，治同。

善忘

时疫善忘者，畜血之所致也，畜血在上焦，其脉芤，胸前及心下必痛，必拒按而软，犀角地黄汤主之，畜血在中焦，其脉或芤，或弦，或涩，两胁及脐上，必有痛处拒按而软，桃仁承气汤主之，畜血在下焦，其脉必沉结，脐下必有痛处拒按而软，抵当汤主之，善忘虽为畜血主症，然必验之大小便，屎虽僇，大便反易，其色必黑

，小便自利，方为畜血之的证，否则，仍当叁之多言 g 诸法治之。

沉昏

时疫沉昏，热入至深，极险症也，盖热初蒸及心之经，则心神不安，多梦呓，醒时自清，蒸心之经渐深，则心神渐烦，多言，所言皆日用当行之事，无糊涂语，蒸及心包，则精神间有昏处，多言间有糊涂语，犹清白语居多，迨蒸心包渐深，则心神昏处居多，言多妄见妄闻，甚至疑鬼疑神，非人所见闻者，犹省人事也，至热直入心脏，则沉昏全不省人事矣，此热入浅深之次第，见证轻重之辨也，所以多言，热之浮浅者，梔，芩，知，膏可解，发狂，热之深结者，硝，黄可解，至沉昏，热之至深者，非犀角，黄连，羚羊角，牛黄莫能解也，沉昏虽系热深，更有夹痰气，夹胃结，夹血结之分，胸满舌白，系夹痰气，当加川贝，瓜蒌，半夏，莱服子於犀，连诸药中，舌黄及燥黑，腹满硬痛者，当加犀，连於三承气汤中，痛而软者畜血，加桃仁，丹皮，赤芍於犀，连药中，治沉昏之大法备矣，以上皆实症，更有虚症，亦所当知，屡经汗下清利之後，表无热，胸腹无阻，二便自利，而神情由倦而渐昏，由昏而渐沉，乃大虚之危症，大剂生脉散加桂，附，术，苓，芍，急救其阴伤，亦不逮矣。

循衣摸床撮空

时疫循衣摸床撮空者，热盛神昏而四肢实也，当察其舌，舌胎白或无胎，有热无结也，犀角，黄连，石膏为主，舌有燥胎，或黄黑燥裂芒刺，有热有结也，大黄，芒硝为主，屡经汗下後，胸胁仍有拒痛者，邪未尽也，仍宜清利，无拒痛者，阴虚而阳亢也，生地，麦冬，枣仁，茯神安神为主。

多睡

时疫初起多睡，兼身重者，热邪阻滞其经脉也，有汗，白虎汤，无汗，或加麻黄，屡经汗下後，表热愈甚，二便俱利而身痛多睡者，阴伤也，四物，六味，生脉三方合用，大剂养阴方效，失治即危，服此数剂，身痛已和，表热退而仍多睡者，於三方中加生枣仁即愈，若夫平素脾虚多睡，多痰嗜睡者，一受疫症必更嗜睡，当於时疫药中叁之以理脾消痰之品。

身冷

诸病身冷，皆属阴症，在峙疫多属热症，须从气，色，神，脉，舌胎中辨其端倪，果系时疫，则当分初中末以治之，不可紊也，时疫初起，往往有身冷自利，腹痛作呕，全似阴症者，若舌有厚白胎，身有秽气，心烦多汗，面色油垢，小便黄短数，有一二证现，便是疫邪直入太阴，先後表，非真阴寒症，兼呕利，藿香正气散，

四苓散，无呕利，达原饮，服一二剂後，即发势矣，时疫传变发热之後，沉昏，舌燥，腹满，便秘，而身冷者，先表後症，三承气，大柴胡选用，无结症者，白虎汤，时疫末路，屡经汗下，表无邪，胸腹无滞，二便自和而身冷者，当以脉为主，脉虚细不振者，用药太过而成脱症也，急宜温补，少缓即死，生脉散加，术，苓，芍，平补阴阳，冷甚者加熟附子，时疫身冷一症，最难下手，初起时，若寒热不辨，且勿妄投汤剂，当少待之，多则一二日，少则半日，多有自行传变，即发热烦渴者，此时则易於用药，若已经发热传变之後，变为身冷，则自有口燥舌乾，不得卧诸症在，此时药不可缓，缓则热深厥深，虽下後厥回，往往亡阴而死，身冷与恶寒不同，而病机颇同，当与恶寒条叁看。

呃逆

时疫呃逆与伤寒不同，伤寒呃逆，虚实寒热俱有，时疫呃逆惟热结下焦而已，凡见呃逆，即当下之，下之不止，按其脐腹有硬痛拒按处，仍当下之，有下至十数次方止者，总之逐尽结热，肠胃通达，其呃自止，慎不可用丁香柿蒂汤，治呃而遗结热，致成危证也。

吐蛔

伤寒吐蛔，多寒热错杂，时疫吐蛔，则有热无寒，治此症之当汗，当清，当下，一以传变之大势为主，惟加乌梅，黄连以安之，慎勿用乌梅圆中诸辛热药，致成危笃也。

广瘟疫论卷之四

汗法

时疫贵解其邪热，而邪热必有着落，方着落在肌表时，非汗则邪无出路，故汗法为治时疫之一大法也，但风寒汗不厌早，时疫汗不厌迟，风寒发汗，必兼辛温辛热以宣阳，时疫发汗，必兼辛凉辛寒以救阴，风寒发汗，治表不犯，时疫发汗，治表必通，其不同有如此，故方疫邪传变出表时，轻者，亦可得表药而汗散，若重者，虽大剂麻黄，羌，葛，亦无汗也，以伏邪发而未尽之故，亦有不用表药，而自汗淋漓，邪终不解者，盖此汗缘热郁蒸而出，乃邪汗，非正汗也，必待伏邪尽发，表全彻，然後或战汗，或狂汗而解，所谓汗不厌迟者此也，幸凉发汗，则人叁败毒散，荆防败毒散之类是，辛寒发汗，则大青龙，九味羌活，大羌活之类是，发表兼通，则吴氏三消饮，六神通解散，防风通圣散之类是，更有不求汗而自汗解者，如热闭甚，用大承气以通其，一不已而再，再不已而三，直待邪逐尽，表自和，多有战汗而解，此不求汗而自汗解者一，反如热燥甚，病者思得凉水，久而不得，忽得痛饮，饮盏落枕而汗大出，汗出即解，此不求汗而自汗解者二，又如平素气虚，屡用汗药不得汗，後加人叁於诸解表药中，覆杯立汗，此不求汗而自汗解者三，又如阴虚及夺血，枯竭之极，用表药全然无汗，用大滋阴润燥生津药数剂，而汗出如水，此不求汗而自汗解者四，总之疫邪汗法，不专在乎升表，而甘乎通其郁闭，和其阴阳，郁闭在表，辛凉辛寒以通之，郁闭在，苦寒攻利以通之，阳亢者饮水以济其阴，阴竭者滋润以回其燥，气滞者开导，血凝者消瘀，必察其表无一毫阻滞，乃汗法之万全，此时疫汗法，理不同於风寒，谨撮诸汗症，详列於左。

发热、恶寒、无汗、头项痛、背痛、腰痛、肩臂痛、膝胫痛、周身肢节痛

下法

时疫下法，与伤寒不同，伤寒下不厌迟，时疫下不厌早，伤寒在下其燥结，时疫在下其郁热，伤寒症当下，必待表症全罢，时疫不论表邪罢与不罢，但兼衰症即下，伤寒上焦有邪不可下，必待结在中下二焦方可下，时疫上焦有邪亦可下，若必待结至中下二焦始下，则有下之不通而死者，伤寒一下即已，仲景承气诸方，多不过三剂，时疫用下药，至少三剂，多则有一二十剂者，时疫下法有六，结邪在胸上，贝母下之，贝母本非下药，用至两许即解，结邪在胸及心下，小陷胸下之，结邪在胸胁连心下，大柴胡汤下之，结邪在脐上，小承气汤下之，结邪在当脐及脐下，调胃承气汤下之，痞，满，燥，实三焦俱结，大承气汤下之，此外又有本质素虚，或老人，久病，或屡汗屡下後，下证虽具而不任峻攻者，则麻仁丸，蜜煎导法，猪胆导法为妙，下法之轻重缓急，总以见证为主，详列於後。

急下证舌乾、舌卷、舌短、舌生芒刺、舌黑、齿燥、鼻如烟煤、胸腹满痛、狂、沉昏、发热汗多、身冷、呃逆

当下证舌黄、善忘、多言、协热利、头胀痛、烦躁

缓下证舌淡黄胎、微渴、大便闭、小便黄赤、潮热、齿燥以上诸症，缓下者不下，则必渐重而为当下症，当下者缓下，则必加重而为急下症，急下者失下，则後虽下之，多不通，而致结热自下逆上，胀满直至心下，又逆上透过膈膜有至胸满如石，咽喉锯响，目直视反白，或睛盲，瞳散，耳聋，九窍不通，虽有神丹，莫之能救矣，外更有畜血畜水诸证下法，前已散见诸条，兹再详列以便翻阅。

畜水证小便不利、大便微利

畜血证小便自利、大便黑、他若畜水畜血，在胸胁不当下者，此不赘。

清法

时疫为热证，未有不当清者也，其在表宜汗，使热从汗泄，汗法，亦清法也，在宜下，使热从下泄，下法，亦清法也，若在表已得汗而热不退，在已下而热不解，或本来有热无结，则惟以寒凉直折，以精其热而已，故清法可济汗下之不逮，三者之用，可合而亦可分，时疫当清者十之六七，则清法不可不细讲也，凡清热之要，在视热邪之浅深，热之浅者在营卫，以石膏，黄芩为主，柴胡，葛根为辅，热之深者在胸膈，花粉，知母，蒺仁，栀子，豆豉为主，热在肠胃者，当用下法，不用清法，或下而兼清亦可，热入心包者，黄连，犀角，羚羊角为主，热直入心脏，则难救矣，用牛黄犹可十中救一，须用至钱许，少则无济，非若小儿惊风诸方，每用分许，即可有效，当清诸症，谨列於左。

热在营卫证身热汗自出、不恶寒反恶热、身重、头面项红肿、周身红肿、斑疹、鼻孔乾、唇燥、烦躁、遗尿、舌胎白

热在胸膈证身热反减、渴、呕、咽乾、多言、胸前红肿、舌胎厚白

热在肠胃证便血、便脓血、馀悉见下证条中

热在小包及心证狂、沉昏、多睡、舌黑

和法

寒热并用之谓和，补泻合剂之谓和，表双解之谓和，平其亢厉之谓和，所谓寒热

并用者，因时疫之热，夹有他邪之寒，故用此法以和之也，凡方中有黄连与生姜同用，黄芩与半夏同用，石膏与苍术同用，知母与草果同用者皆是，所谓补泻合用者，因时疫之邪气实，人之正气虚，故用此法以和之，凡方中有参，归，芍与硝，黄，枳，朴同用者是，所谓表双解者，因疫邪既有表症，复有症，故用此法以和之，凡方中有麻，葛，羌，防，柴，前，与硝，黄，梔，芩，苓，泽，枳，朴合用者是，所谓平其亢厉者，因时疫之大势已去，而余邪未解，故用此法以和之，或用下法而小其剂料，缓其时日，或用清法而变其汤剂，易为丸散者皆是，凡此和法，虽名为和，实寓有汗下清补之意，疫邪尤有宜和者，凡热不清，用清凉药不效，即当下其热之所附丽，盖无所附丽之热，为虚而无形之气，如盛夏炎蒸，遇风雨即解，故人身之热，气清即退，有所附丽之热，为实而有物，加洪炉柴炭，虽沃以水，尤有沸腾之忧，必撤去柴炭而热始退，凡热之所附丽，非痰即滞，非滞即血，径清其热，不去其物，未能有效，必视其附丽何物，於清热诸方加入何药，效始能捷，此和法，之精微神变者也，宜和之症，详列於左。

寒热往来、盗汗、口苦、咽乾、头眩、舌强、渴胸胁满、耳聋、小便黄、呕吐、下利而心下痛、口乾舌强而恶寒、大小便闭而寒热、痞满而悸、二便自利而舌胎、形体瘦损而舌胎、凡此表虚实寒热相兼者，不可枚举，引此数端，可以类推，其有似和而实非和证者，详後辨似条。

补法

时疫本不当补，而有屡经汗下清解不退者，必待补而愈，此为病药所伤，当消息其所伤，在阴在阳，以施补阴补阳之法，疫邪为热症，伤阴者多，然亦有用药太过而伤阳者，则补阴补阳，又当酌其轻重，不可偏废，凡已经汗下清和而烦热加甚者，当补阴以济阳，所谓寒之不寒，责其无水者是，六味，四物，生脉，养荣诸方酌用，当其汗下清和，热退而昏倦痞利不止者当补阳，所谓养正以却邪者是，四君，异功，生脉，六君，理中，建中，附子等方酌用，诸症详後。

当补阴证舌乾无胎、舌黑无胎、耳聋、目直视、目不明、服清凉药渴不止、服清凉药烦热加甚、服攻下药舌胎愈长、服攻下药舌胎芒刺燥裂愈甚、服清凉药身热愈甚、身体枯瘦、用利水药小便愈不通、腰膝痿软、周身骨节痛不可移动、多睡

当补阳证多冷汗、汗出身冷经日不回、小便清而多、大便利清、呕吐用清热开导药愈甚、自利用清下药愈甚、痞满，外此，更有四损，四不足，三复症，当补详见後。

四损

大劳，大欲，大病，久病後为四损，气血两虚，阴阳并竭，复受疫邪，正虚则邪入

愈深，邪深则传化难出，汗下伤正而正脱，补助郁邪而邪锢，多不可治，然补泻兼施，间有愈者，有补泻合用之法，有先补後泻之法，有先泻後补之法，凡人叁败毒散，人叁白虎汤，黄龙汤，竹叶石膏汤，皆补泻合用之法也，先用补剂，後施汗下，先补後泻之法也，先用汗下，後施补剂，先泻後补之法也，当询病之来路，斟酌施治，尤当审现在之症，若纯见实证，亦不可以疑似之见误人，大凡周身俱见大实大热之症，而一二处微见虚象，则吃紧照顾其虚，周身俱见虚象，而一二处独见实证，则吃紧斡旋其实，此治病之权衡也，若夫汗之而表症愈增，如头痛身痛更甚之类。清下而 症愈增，如烦渴痞满更甚之类，则大虚有盛候也，急宜补之母疑，既辨其症，尤当细辨其脉，凡遇脉之浮候盛大者，须谨察其沉候有无力处，六部脉皆盛者，须谨察其一部有独无力处，果得其一部一候之真无力，便可略其诸部诸候之假有馀，从而施治，有独见若神之妙，夫既询得其来路之大概，又察得其轻重之确凭，再加之脉理精详，则烛照无遗矣，其损证之状甚多，当叁後四不足条看。

四不足

四损由人事，四不足由天禀，四损在暂时，四不足在平素，然四不足亦有由四损而来者，不可以四损之外便无不足，四不足者，气血阴阳也，气不足者，少气不足以息，语言难出也，感邪虽重，反不成胀满痞塞，凡遇此症，纵宜宣伐，必以养气为主，血不足者，面色痿黄唇口刮白也，感邪虽重，面目反无阳色，纵宜攻利，必以养血为主，阳不足者，或四肢厥逆，或肌体恶寒，恒多泄泻，至夜益甚，或口鼻冷气，受邪虽重，反无发热胎刺燥渴，凡遇此等症，纵欲攻利清热，必先之以温补，待其虚回，实证全见，然後以治实之法治之，阴不足者，自然五液枯乾，肌肤甲错，感邪虽重，应汗无汗，应厥不厥，遇此等症，纵宜攻利，必先之以养阴，待其气化津回，邪多不治自退，设有未退，酌用清利，攻利若早，其病益甚，以上四不足，合前条四损，总不可正治其邪，必以养正为要，先服养正药，待其实症悉见，方可攻邪，若服攻邪药，虚症复见，仍当调补其虚，养正以和邪，邪以安正，互相加减，迭为进退，直待邪尽去而正不伤，方为善治。

三复

三复者，劳复，食复，自复也，劳复者，大病後因劳碌而复也，不必大费气力，即梳洗沐浴亦能致复，复则复热，诸证复起，惟脉不沉实为辨，轻者静养自愈，重者必大补以调其营卫，和其脏府，待其表 融和方愈，误用攻下清凉，必致不救，安神养血汤主之，若因饮食过多而复者，舌胎必复黄，轻则损谷自愈，重则消导始愈，若故自复者，乃伏邪未尽也，当问从前所见何证，服何药而解，今仍用前药以涤其馀邪则愈，时疫复症，有复至再三者，屡复之後，必兼四损四不足症，宜叁前条加减进退之法治之。

辨似

凡病皆以虚实寒热四字为大纲，时疫何独不然，但虚实寒热之真者易辨，似者难辨，前所列时疫表诸证，皆实邪热邪，而实热中亦有虚寒，四损四不足，皆虚邪寒邪，而虚寒中亦有实热，余於逐条下已细辨之矣，然有实症似虚，虚症似实，热症似寒，寒症似热，尤不可不细辨，故复通论而详述之，所谓实症似虚者，即以表症论之，头痛发热邪在表也，其脉当浮，证当无汗，而反自汗，脉无力，用发表药而身反疼痛，则似虚矣，故人惑於多自汗而误用桂枝汤者有之，惑於脉无力而引仲景太阳篇，发热恶寒脉微弱为无阳，而误用建中汤者有之，惑於身疼痛，而引仲景若不瘥身体疼痛当温其，误用四逆汤者有之，不知此等症，在时疫中，皆在表实症之似虚者也，其自汗者疫热自蒸出於表，非表虚也，其脉无力者，热主散漫，散漫则脉软，非比寒主收敛而脉紧也，身体反疼者，伏邪自而渐出於表，非比阳虚不任发表也，此表症之实症似虚者也，又以半表半论之，寒热往来胸胁满，邪在半表半裏也，其脉当弦，其口当渴，而有脉反沉口不渴者，则似寒矣，故人惑於脉沉，而以胸胁满为太阴，口不渴为内寒，而误用理中者有之，不知此症，在时疫中，皆半表半热症之似寒者也，其脉沉者，邪伏在募原而未出表，故脉不浮，非阳虚也，其不渴者，邪未传变，未入胃府，故不能消水，非内寒也，此半表半之似寒者也，又以症论之，口燥咽乾不得卧，邪在也，其脉当滑，其身当热，其便当结，”按滑当作洪，经云，滑者，阴气有馀也，主痰饮宿食吐逆诸症，洪为气血燔灼之候，主烦，主咽乾，表俱热，二便涩，伤寒阳明经病〔，而脉反沉微涩弱，身反四逆厥冷，大便自利，则全似虚冷矣，人惑於脉之沉微弱涩而用叁，者有之，惑於厥逆而用桂，附者有之，惑於自利而用叁，术，乾姜者有之，不知此等症，在时疫皆热之似寒也，实之似虚也，其脉沉微弱涩者，乃邪热结於肠胃，气不达於营卫也，其身反厥冷者，邪热结於，结於下，气不达於外，通於上也，其自利者，乃热结旁流也，此证之实证似虚，热症似寒者也，总之，时疫为热因，与风寒之寒因大异，故脉症虽有似虚似寒之时，而一辨其为时疫，则属邪自外至，邪气盛则实，大都反见虚寒假象，明眼人不当为所惑也，所谓虚证似实者，即以表证论之，头痛发热身疼痛，自汗脉浮大，邪在表也，而屡用表散清凉药，不惟不减，其症转甚者，非药力之不到，乃正气不能传药力达表，阴液不能随阳气作汗也，此邪在表时，虚症以之似实者也，气虚者，加叁，於表药即汗，阴竭者加润剂於表药即汗，若不知其气血之两亏而宣表不已，势心暴厥而成脱症矣，更以半表半论之，胸胁痛，耳聋，呕吐，如疟状，脉弦，邪在半表半也，而屡用和解消导药，不惟不减，其症更加者，非药力之不到，乃中焦脾胃伤而气不运，肝木伤而火燥逆也，此疫邪在半表半时，虚症之似实也，必合四君、六君於和解药中，合四物於清解药中，始能战汗而解，若更消导清解不已，必至胃气绝而死，更以症论之，舌胎黄黑裂燥芒刺，胸胁脐硬痛，大小便闭，六脉数大，邪在也，而屡用攻利药，或总不得利，或利後更甚，非药力之不峻，乃正气不能传送肠胃，血液不能滋润肠胃也，气虚者助气以资传送，血枯者养阴以藉濡滑，气行津化，方得通利，此疫邪传时，虚证之似实者也，若不知其亏竭而恣意攻利，必沉昏痿顿而死，总之，药不中病，则伤正气，伤其下，则正气浮越而上逆，伤其中，则正气解散

而外张，脉症虽有似实似热之时，而一询其来路，若治之太过，则属气从内夺，正气夺则虚，明眼人不当为所惑也，夫一证而虚实互异，用药稍讹而生死攸分，将以何者为辨症之把柄乎，曰，以开卷所列气，色，神，脉，舌胎，辨其是疫与非疫，以曾经误，治与未经误治，辨其时疫之为实为虚，则得其大纲，更细玩前所列各症，条分缕析之详，则得其细目，则似是而非之症断不能惑矣，余於前各条下，每症已细辨其虚实，而此复重言以通论之者，正以前散且於诸条，恐读者略过，故复总论以提撕其为吃紧处也，至若寒症似热，则伤寒诸症有之，时疫绝无，故不论及云。

遗症（属病后不表里证）

发肿

时疫大势已平，寒热已解，而面目肢体浮肿，有食滞中宫，水停心下，气复未归三种，当分别以施治，食滞中宫者，乃病後脾胃大虚，不能消谷，病者胃中枯燥，偏欲多食，食停心下脐上，则水不得上输於肺，肺亦不能通水道下输膀胱，故溢於肢体而为浮肿，其症以心下脐上有硬处按之则痛为异，小便或利或不利，当用平胃散加枳实，山楂，麦芽，莱菔子，青皮，神僭为主，硬处消，则肿自愈，或加苓，泽，兼利水亦可，水停心下者，乃脾虚不能消水也，与食滞异者，心腹无硬痛，小便不利也，用苓，泽，车，前，木通之类利其小便而愈，气复未归者，吴又可所谓病後气复血未复，气无所归，故作肿也，不可治肿，调其饮食，节其劳役，静养自愈，其异於停水食滞者，水停，身重小便不利，气肿，身轻小便自利，食滞，腹中有结，气肿，腹中自和也。

发颐

时疫愈後有发颐者，乃馀热留於营血也，速以解毒清热活血疏散为主，误则成脓不出，而牙关不开，咽喉不利，多不能食而死，毒内陷而复舌燥神昏亦死，出脓後气虚血脱亦死，故宜早治也，古方以普济消毒饮为主，发在耳後，以柴胡，川芎为君，在项下，以葛根为君，在项後或巅顶，加羌防，此症不可轻补於未溃之先，补早必成脓，尤不可纯用寒凉於将发之际，恐闭遏而毒不得发，故必兼疏散为要，外治，以葱水时时浴之。

发疮

时疫愈後发疮者极多，馀热淫於肌肉也，多服清凉养气血药自愈。

发痿

时疫愈後四肢不能动移者，热伤筋脉也，吴氏诸养荣汤酌用，轻者粥食调理，自愈。

索泽

时疫愈後，身体枯瘦，皮肤甲错者，热伤其阴也，养阴为主，吴氏诸养荣汤酌用，亦有粥食调理自回者。

发蒸

时疫愈後，有发骨蒸如劳瘵者，乃馀热留於阴分也，不可以其羸瘦而遽用虚损门治法，必察其六府，有结邪，则仍攻其邪为主，次察其经络，有壅瘀，则仍通其壅瘀为主，次察其气道，有痰涎，则仍利其痰涎为主，数者俱无，然後以清热为主，或无邪而阴伤，方可纯用养阴之药，或分别其馀邪之轻重，亏损之多少，而兼用养阴清热药进退加減以和之，更妙，

妇人

妇人时疫，悉与男子同，惟当经期，则治法略异，以其关乎血室也，凡遇感疫值经期者，治法必兼少阳，以少阳与厥阴为表，厥阴为血室，血室一动，邪必乘虚而犯之，须分别经水适来受疫而遽止，或经水适来受疫而自行，与经水适断而受疫，辨此三者则虚实自见，凡经水适来而受疫气遽止者，必有瘀血，要再察其胁腰少腹有牵引作痛拒按者，必以清热消瘀为主，小柴胡加赤芍，延胡，桃仁，归尾，丹皮，凡经水适来而受疫气，疫病虽发而经水照常自行者，不必治其经血，但治其疫邪，而病自愈，盖病本未犯血室，故经血自行如常也，仲景所谓勿犯胃气及上二焦必自愈者，正指此，非谓总不用药也，凡经水适断而受邪者，经行已尽，则血海空虚，邪必乘虚而陷入血海，若见腰协及少腹满痛者，大柴胡汤加桃仁，赤芍，逐其血室之邪始愈，凡妇人受疫，但见昼日明了，至夜，即当询其经期，以防热入血室之渐。

妊娠

妊娠感时疫，须治之於早，则热不深入而伤胎，当汗当清之症，当速治固不待言，当下之症，尤不可迟，若因妊娠忌下伤胎之说，因循略迟，则胎受热蒸而反易堕，一见症，速下其热，其胎反安然无事，盖有病则病受之，内经所谓有故无殒者，乃历验不诬者也，妊娠受疫，当下失下，至於舌黑腰痛，少腹下坠至急，则其胎多死腹中，自欲堕矣，此时下亦堕，不下亦堕，然下之胎堕，母犹可救十中二三，不下则母无生理，胎亦不能独存，同一堕胎，而此善於彼，当明言於病家，而後施治下药，虽三承气皆可用，惟芒硝当慎，以其专主伤胎，非大实大热大燥，不可试也

。

小儿

小儿受时疫，悉与大人同，而时见惊搐，类於惊风，误治多死，用大人治疫清解诸法，减小剂料以治之则愈，小儿不能言，遇当下症，既不知其，复难验其舌胎，则当验其唇，唇赤而燥，即是下症，此幼科之要诀也。

广瘟疫论卷之末

诸方

大青龙汤麻黄、桂枝、杏仁、石膏、甘草（炙）、加姜枣煎六神通解散（槌法有川芎羌活细辛）麻黄（一钱）、甘草（一钱）、黄芩（二钱）、苍术（二钱）、石膏（一钱五分）、滑石（一钱五分）、豆豉（十粒），加葱姜煎九味羌活汤羌活（一钱五分）、防风（一钱五分）、细辛（五分）、苍术（一钱五分）、白芷（一钱）、川芎（一钱）、黄芩（一钱）、生地（一钱）、甘草（一钱）、加生姜葱白煎萎蕤汤（一方有乾葛无菊花）萎蕤（二钱五分）、麻黄（五分）、白薇（五分）、青木香（五分）、羌活（五分）、杏仁（五分）、川芎（五分）、甘草（五分）、石膏（一钱五分）、菊花（一钱五分），白水煎大羌活汤羌活、防风、细辛、苍术、白术、川芎、黄芩、生地、甘草、防己、知母、独活、黄连，白水煎人参败毒散人参、茯苓、甘草、枳壳、桔梗、柴胡、前胡、羌活、独活、川芎、薄荷，加生姜煎吴氏达原饮槟榔（二钱）、厚朴（一钱）、草果仁（五分）、知母（一钱）、黄芩（一钱）、芍药（一钱）、甘草（五分），白水煎小柴胡汤柴胡、黄芩、人参、半夏、甘草，加生姜大枣煎炙甘草汤人参、甘草（炙）、桂枝、阿胶（蛤粉炒）、麦冬、生地、大麻仁，加生姜大枣水酒各半煎柴胡四物汤柴胡、半夏、人参、黄芩、甘草、当归、川芎、白芍、生地，加姜枣煎叁胡三白汤人参（一钱五分）、白芍（一钱五分）、柴胡（二钱）、白芍（一钱五分），白水煎。若脉微弱，口渴心烦，加麦冬，五味子，若烦，口苦，心下痞，加黄连，枳实，若不眠，加竹茹。

清脾饮青皮、柴胡、厚朴、黄芩、半夏、甘草、茯苓、白术、草果，加生姜煎大承气汤大黄（四钱酒洗）、芒硝（二钱）、厚朴（二钱）、枳实（一钱），白水煎小承气汤大黄（四钱）、厚朴（一钱）、枳实（一钱），白水煎调胃承气汤大黄（三钱酒浸）、芒硝（二钱）、甘草（一钱），白水煎人参白虎汤石膏、知母、甘草、人参、加粳米煎黄龙汤大黄（三钱）、芒硝（二钱）、厚朴（一钱五分）、枳实（一钱）、甘草（一钱）、人参（一钱五分）、当归（二钱），加生姜五片大枣一枚煎六味地黄汤熟地、山药、山萸肉、茯苓、丹皮、泽泻，新汲井水煎生脉散人参、麦冬、五味子，白水煎四物汤川芎、当归、白芍、熟地，新汲井水煎越婢汤麻黄、石膏、甘草，加生姜大枣煎阳旦汤桂枝、芍药、甘草、黄芩，加生姜大枣煎黄芩汤黄芩、芍药、甘草，加大棘煎梔子豉汤梔子、香豉，先煮梔子後入和豉白水煎黄连解毒汤黄连、黄柏、黄芩、梔子（等分），白水煎小陷胸汤黄连、半夏、栝蒌实，先煎栝蒌实後入二味白水煎导赤泻心汤黄连（酒洗）、黄芩（酒洗）、山梔（姜汁炒黑）、滑石（飞）、知母（盐水拌）、犀角（镑）、甘草（生）、麦冬（心去）、人参、茯苓（各一钱），加灯心 生姜大枣煎猪苓汤猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石（各一两），白水煎天水散（加朱砂名益元散）滑石（六钱）、甘草（一钱），研细末井水或灯心汤调柴葛解肌汤（槌法加石膏一钱）柴胡、葛根、甘草、黄芩、芍药、羌活、白芷、桔梗，加姜棘煎吴氏三消饮槟榔、厚朴、草果、知母、黄芩

、芍药、甘草、羌活、葛根、柴胡、大黄，加姜枣煎六君子汤人参、白术、茯苓、炙草、陈皮、半夏，加姜枣煎归脾汤（一方无白芍）人参、白术、黄、茯神、枣仁、远志、木香、当归、白芍、炙甘草，加桂圆肉姜枣煎清燥汤苍术（一钱炒）、白术（五分炒）、黄（一钱五分）、人参（三分）、茯苓（三分）、黄连（一分炒）、黄柏（二分酒炒）、甘草（二分）、陈皮（五分）、猪苓（二分）、泽泻（五分）、升麻（三分）、柴胡（一分）、五味子（九粒）、神僮（二分炒）、麦冬（二分）、当归（二分酒洗）、生地黄（二分），白水煎大柴胡汤柴胡（二钱）、大黄（一钱）、枳实（一钱）、黄芩（一钱）、半夏（一钱）、白芍（一钱），加生姜三钱大枣一钱煎吴氏清燥养荣汤知母、天花粉、当归身、白芍、甘草、生地（汁）、陈皮，加灯心煎补中益气汤人参、白术（炒）、黄（蜜炙）、炙草、陈皮、当归、升麻（蜜炙）、柴胡（炒），加姜枣煎三黄石膏汤黄柏、黄芩、黄连、梔子、豆豉、麻黄、石膏，加生姜大枣煎防风通圣散（又名双解散）防风、大黄、当归、芍药、芒硝、荆芥、麻黄、梔子、连翘、甘草、桔梗、石膏、滑石、薄荷、黄芩、白术、川芎，加生姜葱白煎逍遥散柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、甘草、薄荷，加煨姜煎瓜蒂散甜瓜蒂（炒黄）、赤小豆，共为末，熟水或斋水调，量虚实服，或用（口畜）鼻葛根葱白汤葛根、芍药、知母、川芎，加葱白生姜煎平胃散苍术、厚朴、陈皮、甘草，加姜枣煎吴氏承气养荣汤知母、当归、芍药、生地黄、大黄、枳实、厚朴，加姜煎凉膈散芒硝、大黄（酒浸）、山梔、连翘、黄芩（酒炒）、甘草、薄荷，加竹叶蜜煎四苓散（吴氏有陈皮无白术亦名四苓散）茯苓、猪苓、泽泻、白术，白水煎桃仁承气汤大黄、芒硝、甘草、桃仁、桂枝，白水煎茵陈蒿汤茵陈、大黄、梔子，白水煎吴氏举斑汤白芍（一钱）、当归（一钱）、升麻（五分）、白芷（七分）、柴胡（七分）、穿山甲（二钱炙黄），加姜煎犀角地黄汤犀角、生地、丹皮、芍药，白水煎三黄泻心汤（汤液论有黄芩保命集有甘草）大黄、川黄连，以麻沸汤渍之，须臾，绞去滓，温服。

藿香正气散大腹皮、紫苏、藿香、甘草、桔梗、陈皮、茯苓、苍术、厚朴、半夏僮、白芷加姜枣橘皮半夏汤陈皮、半夏，加生姜煎竹叶石膏汤人参、半夏、麦冬、甘草、竹叶、石膏、加粳米生，姜煎大半夏汤半夏、人参、白蜜，以水和药蜜扬之二百四十遍，再煎。

理中汤人参、白术、炒乾姜、炙甘草，白水煎十枣汤芫花（熬）、甘遂、大戟（等分），大枣十枚煮汤，内药末，强人服一钱匕，虚人服半钱匕。

二陈汤陈皮、半夏、茯苓、甘草白虎汤石膏、知母、甘草、加粳米白虎加苍术汤即白虎汤加苍术白虎举斑汤石膏、知母、甘草、人参、白水煎大陷胸汤大黄（二两）、芒硝（一升）、甘遂（一钱为末）、先煮大黄，去滓，内芒硝，煮一二沸，内甘遂末，温服。

大陷胸丸大黄（八两）、芒硝、葶苈（炒）、杏仁（去皮尖各半升），合研，取弹

大一丸，别捣甘遂末一钱，白蜜二合，煮服。

抵当汤水蛭（三十条猪脂熬黑）、虻虫（三十条去头足翅）、桃仁（三十粒去皮尖研）、大黄（四两酒浸），白水煎八珍汤人参、茯苓、当归、熟地、白术、甘草、白芍、川芎、加姜枣煎葛根芩连汤葛根、黄连、黄芩、甘草、白水煎麻仁丸麻仁（二升）、芍药（斤半）、大黄（一斤酒浸）、枳实（一斤）、厚朴（一尺去皮）、杏仁（一升去皮尖熬别作脂），炼蜜丸天王补心丹（一方有石菖蒲四钱无五味子一方有甘草）生地（四两酒洗）、人参（五钱）、元参（五钱炒）、茯神（五钱）、桔梗（五钱）、远志（五钱去心炒）、枣仁（一两炒）、五味子（一两炒）、天冬（一两去心炒）、麦冬（一两去心炒）、当归（一两酒洗）、柏子仁（一两炒去油）、蜜丸，朱砂为衣，灯心汤下。

荆防败毒散荆芥、防风、柴胡、羌活、独活、前胡、川芎、枳、人参、甘草、桔梗、茯苓（等分）、加薄荷叶煎仓廩汤人参、茯苓、甘草、前胡、柴胡、羌活、独活、桔梗、枳、川芎、加陈仓米生姜煎四君汤人参、白术、茯苓、炙甘草、加姜枣煎异功散人参、白术、茯苓、炙甘草、陈皮、加姜枣煎附子汤附子、白术、白茯苓、白芍、人参、白水煎吴氏安神养血汤茯神、枣仁、当归、远志、杏梗、芍药、地黄、陈皮、甘草、加龙眼肉煎建中汤（此小建中汤）桂枝、芍药、甘草、加生姜大枣饴糖煎普济消毒饮黄芩、黄连、人参、橘红、元参、生甘草、桔梗、柴胡、薄荷、连翘、鼠黏子、板蓝根、马屁勃、白僵蚕吴氏柴胡养荣汤柴胡、黄芩、陈皮、甘草、花粉、当归、白芍、生地、知母、加生姜大枣煎吴氏柴胡清燥汤柴胡、黄芩、陈皮、甘草、花粉、知母、加生姜大枣煎吴氏人参养荣汤人参、麦冬、辽五味、地黄、归身、白芍、知母、陈皮、甘草、白水煎吴氏叁附养荣汤当归（一钱）、白芍（一钱）、生地（三钱）、人参（一钱）、附子（七分炮）、炒乾姜（一钱）、白水煎犀角大青汤犀角（上）、大青（中）、玄叁（中）、甘草（下）、升麻（中）、黄连（中）、黄芩（中）、黄柏（中）、山梔（中）、水二鍾煎一鍾柴葛五苓散柴胡、葛根、茯苓、泽泻、猪苓、白术、桂枝